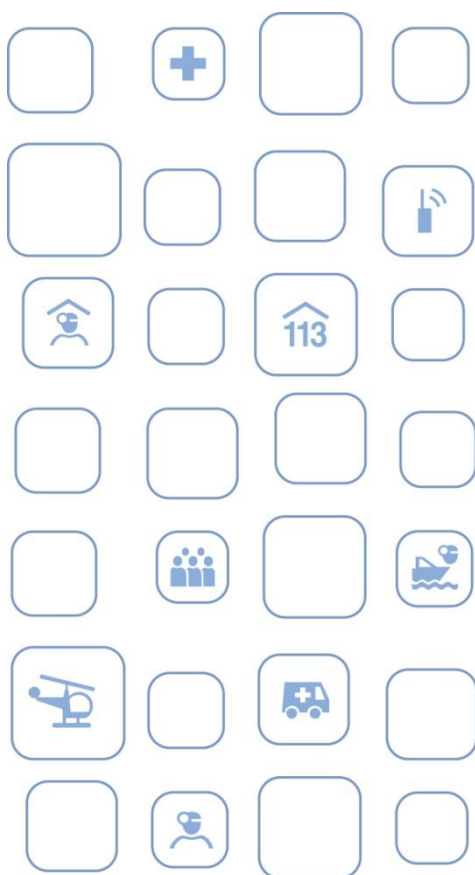


Sluttevaluering av SAMLOK



 KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helse- tjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste i Norge		KOKOM RAPPORT	
		TITTEL Sluttevaluering av SAMLOK	
Postadresse: Møllendalsbakken 9 5009 Bergen Telefon: 55 97 72 60 Web: www.kokom.no E-post: firmapost@kokom.no		FORFATTERE: - Egil Bovim, KoKom (leder) - Nils Petter Bryde, DSB - Magne Rustad, POD - Marianne Storrøsten, DNK	
Layout: KoKom Forsideillustrasjon: Politistasjonen i Drammen © KoKom		ISBN: 978-82-8210-022-9	
	PROSJEKTNR. 250109 GRADERING:	DATO: 18/12 2012	SIDETALL: 42

Sammendrag og tilrådninger

SAMLOK er navnet på prosjekt for samlokalisering av de tre nødetatenes nødmeldesentraler i Drammen (branns 110-sentral, politiets operasjonssentral /112 og helses AMK-sentral/113). Denne rapporten er en sluttevaluering av SAMLOK for å dokumentere resultater av denne.

Helsedirektoratet har hatt ansvar for evalueringen og gjennomføringen er ledet av Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (Kokom) etter avtale med Helsedirektoratet. Representanter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for nødkommunikasjon, Politidirektoratet har bistått i evalueringen.

Prosjektet har i stor grad basert seg på intervjuer med ansatte ved sentralene i SAMLOK, og ansatte i nødetatene (politi, helse og brann og redning) som arbeider i SAMLOKs geografiske nedslagsfelt.

Innledningsvis ønsket vi å gjennomføre en sammenligning mellom sentraler i Drammen, Østfold og Sør-Trøndelag. Dette måtte oppgis da registreringen av virksomhetsdata ved ulike sentraler er så vidt ulik at det ikke er mulig å foreta sammenligninger innenfor evalueringsprosjektets rammer.

De ansatte ved sentralene og i nødetatene i regionen mener gjennomgående at SAMLOK har medført en bedring i tjenesten. Dette gjenspeiles i at det er enklere og mer strømlinjeformet samarbeid ved håndtering av hendelser som krever innsats fra flere etater. En manifestasjon av dette er at trippelvarsling og tverrvarsling mellom sentralene fungerer bedre enn før.

Ansatte i sentralene opplyser at de har fått bedre forståelse for andre etaters problemstillinger, rammevilkår og arbeidsmetoder. Utveksling av erfaringer har medført endringer i den enkelte etats nødmeldesentral. Politiets operasjonssentral og 110-sentralen har nå etablert stillinger for fagutviklere, noe AMK-sentralen har hatt i flere år. 110-sentralen og helses AMK-sentral har tidligere hatt en flat struktur, men har nå, i likhet med hva politiet har hatt i lengre tid, en koordinator/operasjonsleder på hvert skift.

I tråd med intensjonen har SAMLOK fortsatt tre selvstendige sentraler som ligger i samme bygning, og ikke noen sammenslåing av sentralene.

Det er en utfordring at de tre sentralene har ulike geografiske dekningsområder, og at Nødnett fortsatt bare er bygget ut i det området som dekkes av Søndre Buskerud politidistrikt.

Mens sentralene tidligere lå i nær geografisk tilknytning til hhv. sykehus og brannstasjon, er de nå samlet i egen etasje på toppen av politihuset. Dette har medført noe redusert direkte kontakt med personell utenfor sentralen. Dette oppleves på noen områder som en svekkelse, men det understrekes også at det har medført behov for at kommunikasjonen mellom sentralene og tjenestene i Drammen har blitt mer profesjonalisert, og dokumenteres nå i større grad enn tidligere.

Det er ikke rapportert om tilfeller med problemer i forbindelse med taushetsplikt eller lignende i forbindelse med SAMLOK, men det påpekes at samlokaliseringen har ført til bedre forståelse for andre etaters rammeverk også på dette området.

I forbindelse med SAMLOK er det etablert gode tekniske løsninger, som for av hver av nødetatene sannsynlig ikke kunne blitt gjennomført av økonomiske årsaker. Eksempler på det er kjøleløsninger, nødstrøm og redundant strømføring fra trafokiosk til teknisk rom. SAMLOK representerer allikevel tre sentraler for nødetatene som er lokalisert på samme sted, men som har sine egne, separate tekniske løsninger.

- Kapittel 7 i rapporten inneholder konklusjoner: SAMLOK har gjennomgående ført til en «profesjonalisering» av tjenesten, der det har blitt nødvendig å legge mer vekt på dokumentasjon og formelle kontaktformer.
- SAMLOK har medført større gjensidig forståelse mellom de tre sentralene; at de lærer av hverandres erfaringer og implementerer dem (fagutvikling, organisering av team på sentralene, uniformering). Dette kan ses som en «profesjonalisering» av tjenesten.
- Det ligger utfordringer i at sentralene har ulike geografiske nedslagsfelt.
- Utrulling av Nødnett som har medført at 110- og 113-sentralene må forholde seg til to radiosystemer er ikke optimalt.
- Ting som har skjedd parallelt i tid med implementering av SAMLOK (Nødnett, Utøya, generelle endringer i nødmeldetjenesten) medfører at det kan være vanskelig å skille effektene av SAMLOK per se fra øvrige faktorer.
- På grunn av ulike organisasjonsformer før SAMLOK har det ikke vært mulig å fastslå i hvilken grad SAMLOK har ført til endringer i kostnadsnivå i forhold til tidligere.
- Det ligger betydelige, ikke utløste, gevinstpotensialer i f.eks. samkjøring av tekniske løsninger.
- Det har ikke vært mulig å konkludere i forhold til økonomisk vinning eller tap ved implementering av SAMLOK. Dette fordi det ikke finnes sammenlignbare data fra sentralene før SAMLOK.
- Det har ikke vært mulig å påvise noen endring i tjenestekvaliteten til befolkningen. Det betyr ikke at en slik endring ikke finnes.

Utover dette gis en del tilrådinger for fremtidige samlokaliseringsprosjekter.

1. Innholdsfortegnelse

2.	Evalueringsoppdraget.....	6
2.1.	Bakgrunn	6
2.2.	Mandat og målsetting	6
2.3.	Prosjektorganisasjon	7
3.	Beskrivelse av SAMLOK	9
3.1.	Målbeskrivelse.....	9
3.2.	Nødmeldesentraler som inngår i SAMLOK.....	9
3.2.1.	Vestviken 110 IKS	9
3.2.2.	Søndre Buskerud politidistrikt (112)	10
3.2.3.	AMK Buskerud (113).....	10
3.2.4.	Geografiske dekningsområder og samarbeidspartnere.....	11
3.2.5.	Nødmeldesentralene dekker områder med ulike sambandssystemer	12
4.	Gjennomføring av SAMLOK-evalueringen.....	13
4.1.	Planlegging og informasjonsinnhenting	13
4.2.	Hva er skrevet tidligere om samlokalisering av nødmeldesentraler.....	14
4.2.1.	Litteraturstudier	14
4.2.2.	Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten.....	15
4.2.3.	Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten	15
4.2.4.	Rapport fra 22. juli-kommisjonen.....	16
4.2.5.	SINTEFs evaluering av prosessen frem mot SAMLOK.....	17
4.3.	Datainnsamling.....	17
4.3.1.	Virksomhetsdata.....	17
4.3.2.	Intervjuer	19
4.3.3.	Teknisk gjennomgang.....	20
5.	Funn.....	21
5.1.	Operasjonelle funn	21
5.1.1.	Felles gjensidig forståelse	21
5.1.2.	Geografisk nedslagsfelt	21
5.1.3.	Sentralenes lokalkunnskap	22
5.1.4.	Trippelvarsling	22
5.1.5.	Grad av samhandling i SAMLOK	23
5.1.6.	Støtte fra sentralene under aksjoner	24
5.1.7.	Sentralenes forståelse for arbeidsforholdene ute i tjenestene.	24

5.1.8.	Samhandling lokale ressurser	25
5.2.	Resultater av SAMLOK i forhold til prosjektets målbeskrivelse	25
5.2.1.	Ansatte	25
5.2.2.	Økonomi	27
5.2.3.	Innovasjon	27
5.2.4.	Samarbeid:.....	28
5.2.5.	Kvalitet.....	31
5.3.	Teknisk samordning.....	32
5.3.1.	De ulike tekniske komponentene.....	32
5.3.2.	Infrastruktur	32
5.3.3.	Støttesystemer	35
5.3.4.	Kommunikasjonssentralløsning levert i Nødnettprosjektet	37
5.3.5.	Annet	38
6.	Eksterne faktorer som kan ha påvirket SAMLOK	38
6.1.	Innføring av Nødnett	38
6.2.	Terroraksjonene 22. juli 2011.....	39
6.3.	Generelle endringer i nødmeldetjenesten	40
6.4.	Effekter av SAMLOK vs. effekter av eksterne faktorer	40
6.5.	Sammenfallende eksterne faktorer.....	40
7.	Konklusjoner og tilrådinger	41

2. Evalueringsoppdraget

2.1. Bakgrunn

Nødmeldetjenesten i Norge består av separate sentraler for hver nødetat. Pr. 1. november 2012 har politiet 27 sentraler som besvarer henvendelser til 112, brann og redning har 22 som besvarer henvendelser til 110 (antallet er vedtatt redusert til 20), mens helse har 19 sentraler som besvarer henvendelser til 113.

Politiets sentraler er lagt til politidistrikt, der de i tillegg til å ta imot henvendelser, utalarmerer ressurser, og leder den operative tjenesten.

Branns sentraler (110-sentraler) opererer i all hovedsak innenfor politidistrikt som geografiske grenser, og står for mottak av henvendelser, ut alarmering av brannvesenenes ressurser, og yter bistand til innsatsstyrkene.

Helsetjenestens sentraler (AMK-sentraler) dekker som regel flere sykehus i samme helseforetak. De mottar henvendelser til 113, mobiliserer helseressurser (ambulanser, vaktleger etc.) og bistår helseressursene ved behov.

Felles for alle sentralene er at de er bemannet med fagpersonell, som kan gi råd til innringer før utrykkende ressurser er på stedet.

I Drammen var sentralene lokalisert henholdsvis til politistasjonen, brannstasjonen og sykehuset. Felles for alle sentralene var at de hadde dårlige lokaliteter, og behov for oppgradering.

Lokalt oppsto det et ønske om å se på mulighetene for felles lokaler og dermed gevinst i forhold til teknisk infrastruktur og samarbeid mellom de ansatte i sentralene.

I 2005 ble det inngått en intensjonsavtale mellom politimesteren i Søndre Buskerud politidistrikt, styret for Søndre Buskerud 110 og administrerende direktør ved Sykehuset Buskerud HF om at man skulle samlokalisere de tre etatenes nødmeldesentraler. Prosjektet ble kalt «SAMLOK».

Det ble etter hvert bestemt at sentralene skulle legges til politihuset i Drammen, som ble påbygd med en etasje.

Samlokalisering av nødmeldesentraler er nytt i Norge, selv om flere forsøk har vært gjort på slike etableringer tidligere. På denne bakgrunnen påla Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet å gjennomføre prosjektet for å evaluere effektene av prosessen mot og implementeringen av felles beliggenhet av nødmeldesentralene i Drammen.

2.2. Mandat og målsetting

Evalueringssprosjektet er gitt følgende mandat:

- Det utarbeides et felles evalueringsopplegg hvor hovedvekten legges på den enkelte nødetats erfaringer fra nødmeldesentralene før oppstarten av SAMLOK sammenliknet med erfaringene fra etter samlokalisering.

- Evalueringskriteriene skal i så stor grad det er mulig, være felles og sammenlignbare for de tre nødetatene.
- Data basert på kriteriene innsamles, vurderes og presenteres i rapport.
- Det skal i prosjektet legges vekt på å identifisere de effektene som skyldes selve samlokaliseringen, i motsetning til effekter av endringer i teknologi/ faglig utvikling over tid etc.

Et overordnet mål med evalueringen er å bidra til kvalitetsheving i nødmeldetjenesten i Norge. Evalueringen skal videre gi kunnskap om positive og negative erfaringer av SAMLOK og bidra til målbare forbedringer av funksjonen til nødmeldetjenesten i Norge.

Det er forutsatt at sluttevalueringen av SAMLOK skal munne ut i en prosjektrapport. Styringsgruppen har i møte 24. august lagt opp til at denne rapporten skal være offentlig.

2.3. Prosjektorganisasjon

Oppdragsgiver for evalueringsprosjektet er Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet er prosjektleder, mens utførende enhet er Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom).

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet som har bestått av

- Steinar Olsen, Helsedirektoratet (leder)
- Hans Kristian Madsen, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
- Sture Martin Vang, Politidirektoratet (POD)
- Nina Myren, Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)
- Christel G Meyer, Helse Sør-Øst

Styringsgruppen har hatt 4 møter, av dem har 3 blitt gjennomført som videokonferanser.

Styringsgruppen var i sitt møte 24. august klare på at det er et mål for sluttevalueringen av SAMLOK at man skal konsentrere seg om konklusjoner som det er enighet om. Det endelige ansvaret for konklusjonene ligger hos styringsgruppen, men prosjektgruppen vil være en viktig premissleverandør. Det har derfor vært nødvendig med fortløpende konsultasjoner i løpet av bearbeidelsen av den innsamlede informasjonen.

Det fremgår av Helse- og omsorgsdepartementets brev datert 29.06 2012¹ at deltakende direktorater skulle bidra med tekstinnsnitt der dette var nødvendig for å gjennomføre prosjektet innenfor fastsatt ramme, og bidra med nødvendig skrivestøtte. Det praktiske arbeidet er gjennomført av prosjektgruppen som har bestått av

- Egil Bovim, KoKom (leder)
- Nils Petter Bryde, DSB
- Magne Rustad, POD
- Marianne Storrøsten, DNK

¹ Presisering av oppdragsbrev om sluttevaluering av SAMLOK, HOD juni 2012.

Prosjektgruppen har hatt 3 møter i tillegg til flere runder med kommentarer til rapportutkast etc. Møtene har i størst mulig grad vært kombinert med andre gjøremål (orientering SAMLOK, samtaler nødetater, etc.)

Åge Jensen og Øyvind Hope ved KoKom har foretatt en gjennomgang av de tekniske løsningene ved SAMLOK.

3. Beskrivelse av SAMLOK

3.1. Målbeskrivelse

SAMLOK ble etablert som et prosjekt under ledelse av de lokaler nødetatene, brann og redning, politi og helse. Det ble tidlig etablert en målbeskrivelse for prosjektet.

Visjon: En samlokalisert nødsentral skal være et fyrtårn i den omorganiseringen av nødsentralene som forventes å komme i årene framover. Positive effekter av en samlokalisering skal kunne påvises slik at en samlokalisert nødsentral også eksisterer gjennom den nasjonale omorganiseringen av nødsentraler som forventes å komme.²

Målområder:

Ansatte: Et utviklende arbeidsmiljø, som bygger på gjensidig respekt for hverandres kultur og verdier.

Økonomi: Optimalisert ressursutnyttelse gjennom standardiserte og samordnende driftsløsninger.

Innovasjon: Nytenkende og utviklende hva angår samarbeidsform og felles tekniske løsninger.

Samarbeid: Bidra til at nødmeldetjenesten kan utvikles gjennom samarbeid intern og eksternt.

Kvalitet: Forbedret tjenestekvalitet til innbyggerne igjennom samhandling og felles rutiner.³

3.2. Nødmeldesentraler som inngår i SAMLOK

Nødmeldesentralene for politi, brann/ redning og helse er alle plassert i samme etasje på politihuset i Drammen. Dette innebærer ikke at de er slått sammen til en felles enhet. Den enkelte sentral har fremdeles sin organisatoriske tilhørighet i egen etat, egne beslutningsstøttesystemer og separate nødnumre, og opptrer som selvstendige sentraler.

3.2.1. Vestviken 110 IKS

Vestviken 110 IKS er organisert som et Interkommunalt selskap. Frem til 1. juni 2008 dekket 110-sentralen i Drammen Søndre Buskerud politidistrikt foruten Hof og Lardal kommuner, og deler av Re kommune. Fra 1. juni 2008 dekker sentralen områdene som omfattes av Søndre Buskerud, Nordre Buskerud og Vestfold politidistrikt (Vestfold i 2010). Dette innebærer at sentralen nå dekker 36 kommuner, 20 brannvesen og 35 brannstasjoner (hele Buskerud og hele Vestfold). Den samlede befolkningen i Vestviken 110 IKS sitt område var pr. 1. januar 2012 501 979. Alle fast ansatte operatører fyller kravene som satt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (§ 4-5 *Mottak av nødmelding*): «Nødalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp».

² Arbeidsmøte 17 SAMLOK, 29. februar 2008

³ Arbeidsmøte 17 SAMLOK 29. februar 2008

De aller fleste operatørene har bakgrunn som kommer fra aktiv tjeneste i brann og redning. I tillegg har sentralen en vikarpool på 10 ansatte i brann og redning som er tilleggsutdannet som operatører og tar jevnlige vakter i sentralen.

Antallet operatørplasser er 4, operatører på vakt er normalt 3 til enhver tid. Som en del av innføringen av Nødnett i Nordre Buskerud og Vestfold, har sentralen bedt om at det innføres ytterligere 2 plasser. Disse skal være i beredskap for å håndtere store langvarige hendelser, og som backup sentralplasser for andre 110-sentraler

Vestviken 110 IKS flyttet som første sentral inn i SAMLOKs lokaler 21. april 2009.

3.2.2. Søndre Buskerud politidistrikt (112)

Søndre Buskerud politidistrikt omfatter 9 kommuner i Buskerud og 2 i Vestfold. 112-sentralen i SAMLOK håndterer nødanrop og andre henvendelser fra disse. Befolkningsgrunnlaget var pr. 1. januar 2012 196 905. (REF)

Politiets operasjonssentral skal lede og koordinere den samlede politiinnsatsen på taktisk nivå i politidistriktet og sørge for at meldinger fra befolkningen blir tatt i mot og behandlet jf. Politiets beredskapssystem 1 (PBS 1). Operasjonssentralen er også lokal redningssentral. Det er alltid en operasjonsleder til stedet som er ansvarlig. Operasjonssentralen har 5 operatørplasser og er stort sett bemannet med minimum 2 operatører i tillegg til operasjonsleder, unntaks vis kan man enkelte netter i uken være nede i 1 operatør og operasjonsleder. På dag og kveld er det ofte mer enn 3 operatører. Det er et krav at man har bred erfaring som polititjenestemann/kvinne for å arbeide fast på operasjonssentralen. Det er 2 sivile operatører som går i full turnus, men det er alltid minst 2 politiutdannede til stede på sentralen. Det er noe begrensing i hvilken type oppdrag de sivile håndterer. Alle har gjennomgått opplæring for sentralen og godkjent for arbeid der. Operasjonssentralen tar også i mot alle telefonhenvendelser til politidistriktet utenfor normal åpningstid. Der loggføres alle operative oppdrag i politiets vaktjournal. Alle søk og forespørsler som patruljene har blitt utført av operasjonssentralen.

Politiet flyttet inn i lokalene i 6. etasje 23. juni 2009.

3.2.3. AMK Buskerud (113)

AMK Buskerud er en del av Vestre Viken helseforetak.

Sentralens geografiske dekningsområde er samtlige kommuner i Buskerud, Jevnaker i Oppland, Tinn, Hjartdal og Notodden i Telemark og Svelvik og Sande i Vestfold. Dette sammenfaller ikke med dekningsområdet for Vestre Viken helseforetak, ettersom foretaket også inkluderer kommuner i Akershus og Bærum sykehus. Disse dekkes av AMK Oslo/ Akershus på Ullevål. AMK inngår i Klinikken for prehospitaltjenester, som også omfatter ambulansetjenesten, luftambulansen og pasientreiser.

AMK-sentralen fyller kravene satt i *Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus*, (§8, AMK- og LV-sentralene) «AMK-sentraler og LV-sentraler skal bemannes med helsepersonell.» Nødmeldinger via 113-linjer mottas samtidig av både en medisinsk operatør og en ressurskoordinator. Det betyr at to helsearbeidere lytter til samtalen og kan iverksette

oppgaver samtidig som innringeren gir informasjon. Medisinsk operatør er en sykepleier med spesiell kompetanse i vurdering av hendelser og veiledning i livreddende førstehjelp, samt andre viktige tiltak på skadestedet før lege og/eller ambulanse ankommer.

Antallet operatørplasser er 8, (forberedt ved kabling for ytterligere 2). Bemanningsplanen sier at det skal være 4 operatører på dag, 3 på kveld og 2 på natt i ukedagene. Tre på hver vakt i helg. På grunn av to- og tredelt turnus er det som regel flere operatører på alle vakter. (5-6 dag, 4 kveld, 3 natt).

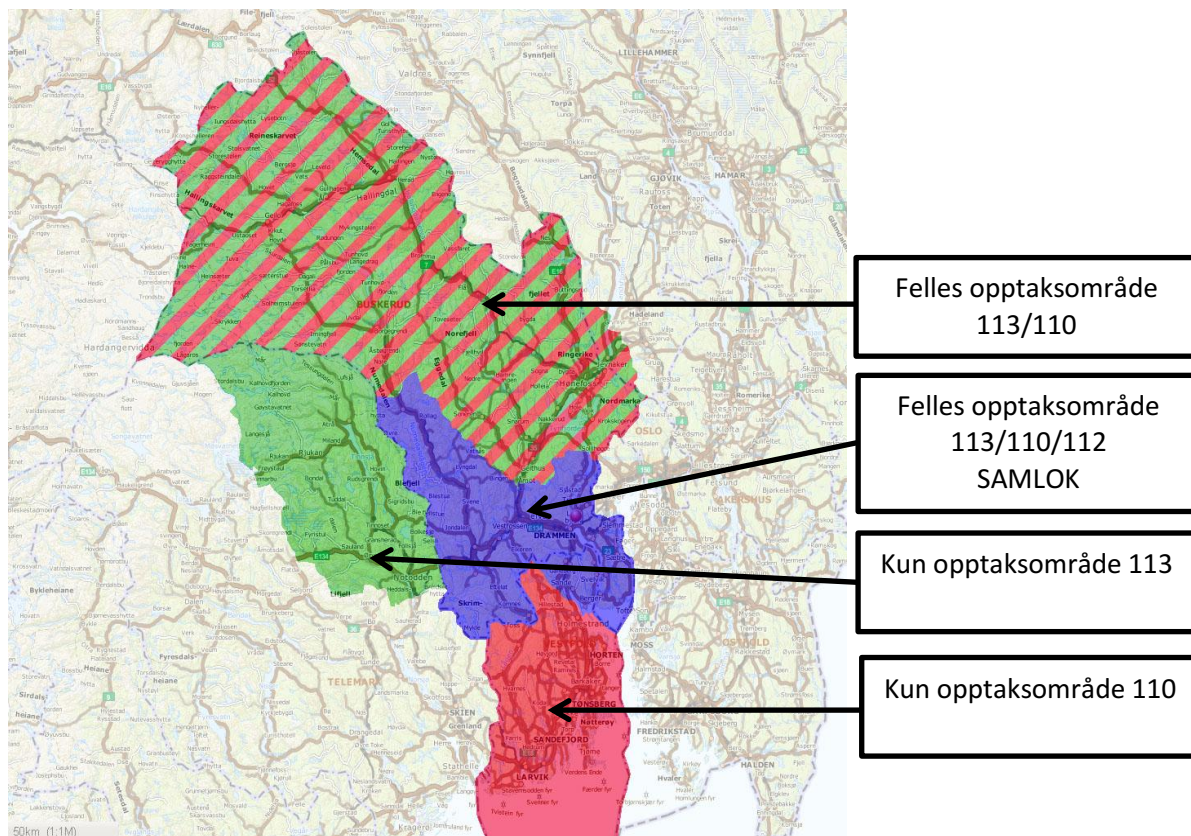
AMK sentralens dekningsområde hadde pr. 1. januar 2012 en befolkning på 300 869 (REF).

AMK flyttet inn i SAMLOK 23. mars 2010.

3.2.4. Geografiske dekningsområder og samarbeidspartnere

Det fremgår av beskrivelsen av den enkelte sentral at nedslagsområdene varierer. De geografiske dekningsområdene vises i kartet i Figur 1.

Figur 1. Oversikt geografiske dekningsområder, SAMLOK.



Det mørkeblå området viser Søndre Buskerud politidistrikt, området dekkes av alle de tre sentralene i SAMLOK. Det rød/ grønn skraverte området er Nordre Buskerud, som dekkes av 110 og 112-sentralene. Det røde området er Vestfold, som dekkes av 110 sentralen. Det grønne området er deler av Telemark, som dekkes av 113-sentralen. Mens hele dekningsområdet til politiet dekkes av Vestre

Viken 110 IKS og AMK Buskerud, må disse i tillegg til å samhandle med aktører innenfor SAMLOK også forholde seg til andre nødmeldesentraler i de øvrige delene av sine dekningsområder.

Tabell 1. SAMLOKs samhandling med andre nødmeldesentraler enn de tre som er samlokaliserte i Drammen.

Samhandlende sentral	Politi	Brann	AMK
Nordre Buskerud politidistrikt		X	X
Vestfold politidistrikt		X	
Telemark politidistrikt			X
Alarmsentralen i Telemark (Brann)			X
AMK Telemark/ Vestfold		X	

Vurderinger av konsekvensene av de ulike geografiske nedslagsområdene er omtalt i kapittel 5.1.2, som omtaler de operasjonelle funnene i prosjektet.

3.2.5. Nødmeldesentralene dekker områder med ulike sambandssystemer

Sammenfallende i tid med etablering av SAMLOK har Nødnett blitt innført i Drammen og deler av sentralenes dekningsområder. Det er kun det geografiske området for Søndre Buskerud politidistrikt hvor Nødnett er bygget ut. Nordre Buskerud og Vestfold var ikke del av første utbyggingstrinn av Nødnett, men etableres i løpet av 2013.

Nødmeldesentralene i SAMLOK har implementert de nye kommunikasjonssentralløsningene som leveres gjennom Nødnettprosjektet. Der Nødnett ikke er etablert opererer nødetatene med sine gamle analoge samband. Det betyr at AMK og 110-sentralen må håndtere både nytt og gammelt samband inn på sine sentraler. Politiet i Søndre Buskerud bruker kun Nødnett, men har politidistrikter rundt seg som opererer i analogt samband.

4. Gjennomføring av SAMLOK-evalueringen

Fra prosjektstart i evalueringsprosjektet var det klart at det lå noen sterke begrensninger i forhold til prosjektgjennomføringen:

- Begrenset tid: Prosjektet startet med styringsgruppemøte 24. august, og det var forutsatt at det skulle være ferdigstilt til årsskiftet. Dette var vesentlig for at prosjektets resultater skulle kunne bidra til pilotering av felles nødnummer i de sentralene som omfattes av dette evalueringsprosjektet.
- Begrensede ressurser: Flere av aktørene gjorde det allerede innledningsvis klart at de bare i begrenset grad kunne stille ressurser til rådighet, på grunn av andre presserende oppgaver som sammenfaller i tid.
- Erfaring fra andre prosjekter av samme art tilsa at tilgjengelig informasjon ville være begrenset, og at informasjon fra ulike etater ikke nødvendigvis ville være fullstendig sammenlignbar.

Aktivitetene i prosjektet kan deles inn i:

- Planlegging
- Innhenting av informasjon
- Bearbeidelse av informasjon
- Konklusjoner
- Rapportskriving
- Prosjektavslutning

4.1. Planlegging og informasjonsinnhenting

Prosjektplanleggingen ble gjort ved at det ble etablert en milepælsplan med ferdigstillingsdato 15.12.2012 som har vært styrende for aktivitetene i prosjektet. Fremdriftsplanen var et levende dokument og ble justert fortløpende i løpet av prosjektperioden.

Prosjektgruppen brukte en vesentlig del av første møte til å bli enige om hvilke kriterier som skulle legges til grunn for evalueringen. Basert på disse ble så informasjon innhentet ved hjelp av litteraturstudier, gjennomgang av informasjon fra sentralene/ tjenesten, og intervjuer med ansatte i etatene. Det ble vurdert å gjennomføre en spørreskjemaundersøkelse, men dette ble forkastet dels av ressursmessige årsaker, dels fordi det ble vurdert vanskelig å lage spørreskjemaer om et i utgangspunktet sensitivt område, og samtidig kvalitetssikre validiteten av svarene. Hovedarbeidet med innhenting av informasjon vil være forbundet med de kriteriene som er definert, og dette vil antakelig utgjøre en meget vesentlig del av arbeidet med prosjektet.

Medlemmene i prosjektgruppen har i varierende grad tatt aktiv del i innhenting av informasjon. Det ble i styringsgruppen gitt uttrykk for at man var opptatt av å begrense ressursbruken i prosjektet. Prosjektleder har derfor deltatt i alle aktivitetene på dette området, men da med varierende bistand fra andre medlemmer i prosjektgruppen.

Det ble gjennomført intervjuer med ansatte ved sentralene og i politi, helse og brann og redning i det geografiske dekningsområdet for SAMLOK. En nærmere beskrivelse av intervjuene er gitt i pkt. 3.3.2

Prosjektgruppen har hatt sine møter i SAMLOKs lokaler. Dette, sammen med at en vesentlig del av intervjuene er blitt foretatt der, har medført at prosjektgruppens medlemmer har fått en viss oppfatning av hvordan sentralene samspiller. I forbindelse et av møtene hadde gruppen en samtale med SAMLOKs styre, som ga prosjektgruppen meget frie hender og stilte alle nødvendige ressurser til rådighet.

Tilfeldighetene ville at det under ett av møtene inntraff en hendelse som krevde samhandling mellom alle sentralene. Det var interessant å se hvordan man delte informasjon og til dels samordnet sin innsats.

Den informasjonen som er blitt innhentet i prosjektet er blitt bearbeidet av prosjektleder. Dels har dette foregått ved hjelp av en database opprettet for dette formålet. Denne inneholder systematisert informasjon fra intervjuene. I tillegg til spørsmålene var det åpnet for fritekstsamtale. Disse er blitt loggført. Etter avtale med intervjuobjektene er databasen og loggen slettet ved prosjektets avslutning.

4.2. Hva er skrevet tidligere om samlokalisering av nødmeldesentraler

4.2.1. Litteraturstudier

Prosjektet har ikke vært i stand til å finne noen litteratur som omhandler at sentraler fra ulike etater flytter til samme lokasjon, men fortsetter å fungere som separate sentraler med ulike nødnumre. Dette fremstår som en unik situasjon; det vanlige er at man, når man samlokaliserer sentralene fra flere etater, også innfører et felles nødnummer med felles mottak av oppringningene.

Kunnskapssenteret⁴ har på oppdrag av Helsedirektoratet foretatt en gjennomgang av relevant litteratur og konkluderer også med at de ikke finner noe vitenskapelig holdbart arbeid på dette området.

Eirik Røsø beskriver i sin mastergradsoppgave⁵ prosessene som førte frem til implementering av SAMLOK, sammenholdt med andre tilsvarende prosjektet i Norge som aldri nådde så langt. Han vektlegger sterkt at det er en forutsetning at prosjektet er godt forankret på lavere plan i nødetatene, og at de som skal arbeide i sentralene har et eierforhold til prosessene.

Det er gjort et flertall utredninger av spørsmål omkring endringer av nødmeldetjenesten i Norge, noen av disse er referert i neste kapittel.

⁴ <http://www.kunnskapssenteret.no/>

⁵ Eirik Røsø, Universitetet i Stavanger, 2010: «Samlokalisering av nødmeldesentraler i Norge - En studie av faktorer som påvirker prosessene» (Masteroppgave)

4.2.2. Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten⁶

Utredningsprosjektet "Forenkling og Effektivisering av Nødmeldetjeneste og Nødkommunikasjon i telenettet" ble startet opp i begynnelsen av 2001, med opprinnelig frist ved utgangen av 2001. Rapporten ble avgitt av daværende Justis- og politidepartementet i 2004. Opprinnelig skulle arbeidet gjennomføres av representanter for relevante departementer og etater. Det viste seg ikke mulig å få enighet om anbefalinger og videre prosesser, så det ble bestemt at Justisdepartementet sto for fullføringen av utredningen og den påfølgende høring. Det ble innhentet virksomhetsdata fra tjenesten og informasjon om tekniske løsninger, ressursbruk og kvalitet og kompetanse i tjenesten. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse til sentralene for å få oversikt over antall henvendelser og ressurser som ble brukt for å håndtere disse. I tillegg ble det gjennomført en publikumsundersøkelse for å avdekke publikums holdninger og kunnskap om nødmeldetjenesten. Det påpekes i rapporten at det var vanskelig å få tak i den nødvendige informasjonen. Utvalget mener dette primært skyldes mangel på tradisjon, rutiner og verktøy for å gjennomføre standardiserte målinger

Den endelige rapporten konkluderer med et sett anbefalinger:

- 112 bør innføres som eneste nødnummer i Norge.
- Hele eller deler av nødmeldetjenestens oppgaver bør organiseres som en felles tjeneste.
- Nødmeldetjenesten bør ha ett organisatorisk tilknytningspunkt.
- Antall nødmeldesentraler bør reduseres betydelig fra dagens antall.

Rapporten inneholder videre noen tilrådninger som bør gjennomføres uavhengig av ovennevnte anbefalinger:

- Det bør gjennomføres tiltak for å minske feilansrop.
- Det bør stilles krav til språkkunnskaper (samisk, engelsk, mfl.) hos operatørene.
- Det bør defineres kvalitetskrav og måleparametre for tjenesten.
- Tiltak for økt teknisk sikkerhet gjennom dobbel tilknytning til offentlige telefonitjenester bør gjennomføres.

4.2.3. Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten⁷

Etter at Regjeringen i St.meld. 22 (2007-2008)⁸ slo fast at den tar sikte på å innføre felles nødnummer og etablere felles nødsentraler for brannvesen, politi og helsetjeneste ble Justisdepartementet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet pålagt å gjennomføre en utredning av hvordan vedtaket best kunne implementeres.

Mandatet var begrenset til at man skulle utrede hvordan regjeringens vedtak om felles nødnummer og felles sentraler kunne implementeres.

⁶ Justis- og politidepartementet, 2004,

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2004/forenkling-og-effektivisering-av-nodmeld.html?id=457648

⁷ Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten - Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2009/forslag-til-fremtidig-organisering-av-no.html?id=566577

⁸ St.meld.nr. 22 (2007-2008).

Utvalget gjennomførte undersøkelser som ga følgende resultater:

- Antallet anrop til 112 og 113 var betraktelig større enn til 110. Volumet av anrop til 112 og 113 var i samme størrelsesorden, men ettersom feilansproprosentsen til 112 er svært høy, fastslås det at 113 har det største antallet reelle henvendelser.
- Basert på 30 testanrop til hver nødmeldesentral fant man at det mediane nasjonale nivået for aksestid til 110 var 10.8 sek, til 112 14,3 sek og til AMK 9.6 sek. Det påpekes i utredningen at det knytter seg noe usikkerhet til dette funnet ved at sentralene kan ha gjenkjent dem som testanrop.
- Rapporten påpeker at nødmeldesentralene fungerer i hovedsak godt, særlig ved hendelser som bare involverer en etat. Ved hendelser som involverer mer enn en etat er det et forbedrings-potensial som medfører at det kan ta for lang tid før nødvendige ressurser er på plass.

Den interdepartementale gruppen ser det som vesentlig at en felles sentral har felles regler for taushetsplikt/ personvern, og at de dekker samme geografiske område for alle etatene.

Utvalget anbefaler en modell der mottak av 112 skjer i en felles sentral som veileder innringer, disponerer ressurser for brann/redning og helse, og viderefører samtaler som gjelder politisaker til politiets operasjonssentral som disponerer politiets ressurser. Det anbefales at sentralene skal ha tilhørighet i et nyopprettet forvaltningsorgan med felles tilhørighet til Helse og omsorgs- og Justisdepartementet. Det påpekes at 112-sentralen likevel må være godt koordinert med nødetatene, slik at tjenesten fremstår som helhetlig.

Antallet sentraler anbefales redusert fra 69 til 7 eller 8.

For å sikre publikums mulighet for direkte kontakt med den enkelte etat anbefales at det opprettes nasjonale direkte numre.

SAMLOK blir omtalt som et godt utgangspunkt for pilotering av felles nødmeldesentral og felles nødnummer.

4.2.4. Rapport fra 22. juli-kommisjonen⁹

22.juli-kommisjonen har i sin fylldige rapport dekket mange områder. Konsekvensene av samlokaliseringen av nødmeldesentralene i Drammen er naturlig nok bare viet begrenset plass. Imidlertid påpeker utvalget at AMK-sentralen hadde problemer med å få kontakt med politiets sentral i Nordre Buskerud politidistrikt. Dermed var de henvist til å basere sine vurderinger på den informasjonen som var tilgjengelig på den samlokaliserte politisentralen, Søndre Buskerud. Kommisjonen påpeker at dette medførte at man misforsto situasjonen, uten at de helt har klart å komme til bunns i hvorfor dette medførte noe misforståelse. Kommisjonens vurderinger underbygger at det er vesentlig at sentraler som er samlokaliserte dekker det samme geografiske området (kommisjonens rapport p.178).

⁹ NOU 2012: 14

4.2.5. SINTEFs evaluering av prosessen frem mot SAMLOK¹⁰

Sintef avga i november 2008 sin rapport om prosessen frem mot implementering av SAMLOK. Rapporten ble avgitt før etatene flyttet sammen, og det er angitt at SINTEF etter noen tids drift i de nye lokalene skulle gjennomføre en tilsvarende prosess for å sammenlikne holdningene til samarbeid og aktivitets- og økonomidata med situasjonen før samlokaliseringen hadde funnet sted. Dette er ikke gjennomført.

Det ble gjennomført en studie der man så på aktiviteten ved de tre sentralene som skulle inngå i SAMLOK i en 2-ukers periode i april 2008.

Eksempler på parametre som ble inkludert i undersøkelsen var:

- Antall oppringinger til hvert av de tre nødnumrene.
- Antall oppringinger til andre telefonnumre ved de tre nødmeldesentralene.
- Oppringinger til nødmeldesentralene fra en av de andre sentralene i området (trippelvarsling).
- Iverksatte tiltak etter innringinger (pr. etat).
- Antall unødige utrykninger.
- Innringinger etter kategori (f.eks. brann, trafikkulykke, vold, sykdom).
- Dag og tid for innringinger til nødnummer og til andre telefonnumre.
- Responstider pr. etat.
- Innringer til AMK etter hastegrad.
- Antall biler mobilisert til hendelsessted.

Man tar noen reservasjoner i forhold til tallene som fremkom:

- Undersøkelsesperioden er kort.
- Det fremkommer at det kan reises tvil om i hvilken grad registreringene ved de enkelte sentralene var like.
- Erfaring tilsier at det kan være krevende å sikre at alle operatører ved samme sentral er sammenfallende.
- De tre sentralene har ikke sammenfallende geografisk dekningsområde. Andre undersøkelser har vist at bruken av nødnumrene varierer i henhold til ulike kriterier, f.eks. alderssammensetning og avstand til sentralen.

4.3. Datainnsamling

4.3.1. Virksomhetsdata

SINTEF gjennomførte som nevnt over en gjennomgang av data vedrørende henvendelser til sentralene og håndtering av disse. Dette ble gjort i form av en prospektiv studie av aktiviteten i sentralene, gjennomført på samme tidspunkt og med felles indikatorer. Dermed var utvalgte data tilgjengelig om «før»-situasjonen.

En måte å vurdere effekten av SAMLOK ville være å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse av situasjonen etter at SAMLOK var implementert.

¹⁰ Samlokalisering av nødmeldesentralene for Søndre Buskerud - En evaluering av prosessen, SINTEF 2008-09-15

Den prospektive studien ble gjennomført 14. - 27. april 2008. Det ble vurdert som eneste alternativ å gjøre «etter»-studien på data fra april 2012. Dette fordi vårt evalueringsoppdrag ble tildelt i august, med bestilt ferdigstilling til nyttår. For å sikre at dataene var sammenlignbare, og ga informasjon om hvilke eventuelle endringer som skyldte selve samlokaliseringen av sentralene i Drammen, ble det vurdert som nødvendig å foreta sammenligning med to andre sett av sentraler. Dette fordi man i tillegg til å samlokalisere sentralene i Drammen også har implementert Nødnett.

Trondheimsområdet ble valgt som kontrollområde som i perioden 2008 -2012, men har ikke gjennomgått hverken samlokalisering eller innføring av Nødnett. Etatenes nødmeldesentraler i Østfold ble valgt fordi man der har implementert Nødnett, men ikke blitt samlokalisert.

Det ble foretatt intervjuer med ledelsen ved de aktuelle nødmeldesentralene. Det var ønskelig å kartlegge i hvilken grad det ville være mulig å innhente de aktuelle dataene, og i hvilken grad dataene var valide.

De tre etatene har svært ulike systemer for beslutningsstøtte etc. Politiet foretar sine registreringer i Politioperativt system (PO), som er i bruk ved alle landets 112-sentraler. Det viser seg imidlertid at en gjennomgang av PO ikke vil gi et fullstendig bilde av sentralens virksomhet, ettersom ikke alle henvendelser registreres. Ofte vil det være slik i en travel hverdag at det ikke er mulig å registrere henvendelser som ikke fører til noen tiltak. En annen vesentlig begrensning ligger i at det i mange tilfeller ikke er tid til å fullføre loggføringen av håndtering av en hendelse før mannskapene blir kastet ut i den neste. Før innføringen av den nye telefonsentralløsningen som kom med Nødnett ble det gjort svært lite registrering av samtaletrafikk. For eksempel er det ikke mulig å finne ut det totale antallet samtaler, hvordan disse fordeler seg på tid på døgnet/ukedag etc.

110-sentralene som ikke har mottatt Nødnettleveransen har også begrensninger i sine registreringer. Det er imidlertid slik at innkomne samtaler til 110 registreres fortløpende, og virksomheten loggføres. Imidlertid er det begrensede muligheter for uthenting av statistikk, og det vil være variasjoner mellom sentraler/operatører i hvordan tiltak registreres, hendelser kategoriseres osv. Med bakgrunn i den mangelfulle muligheten for dokumentasjon av virksomheten i brann/redning er et avansert beslutningsstøttesystem inkludert i Nødnettleveransen. Denne løsningen blir felles for alle 110-sentralene. Dette innebærer at man vil få gode data for tiden etter at Nødnett er blitt implementert.

AMK-sentralene benytter alle det samme beslutningsstøttesystemet, AMIS. Her registreres henvendelsene med klokkeslett, hastegrad, kriterium osv. Det er gjennomført flere prosjekter som har gått på felles registrering mellom ulike sentraler, og erfaringen er at det er store variasjoner mellom sentralene i forhold til hvordan registrering foretas. Det ble også avdekket i vår gjennomgang at det er en viss variasjon i forhold til i hvilken grad henvendelser faktisk registreres.

På denne bakgrunnen vurderte prosjektgruppen at en gjennomgang basert på historiske data i sentralene ville være svært vanskelig. For alle sentralene gjelder at en kunne få noe informasjon ved gjennomgang av logger, men dette ville være så vidt arbeidskrevende at det ville falle utenfor den ressursrammen som var tilgjengelig. I tillegg ville dataene som kom frem ha lav validitet, og ikke kunne benyttes til sammenligning av virksomheten i sentralene.

Det ble derfor konkludert med at informasjonen som var samlet inn ved besøkene i nødmeldesentralene skulle gå inn i bakgrunnsinformasjonen i prosjektet, men at det ikke skulle gjennomføres noen undersøkelse av virksomheten i en to-ukers periode slik det var planlagt.

4.3.2. Intervjuer

Det ble gjennomført semi-strukturerte intervjuer med ansatte i sentralene. Det ble også gjennomført intervjuer med brukere av sentralene.

Det kan synes logisk å henvende seg til innbyggerne når man skal forsøke å finne ut om de har opplevd endringer i tjenestekvaliteten. Dette ville måtte gjøres i form av en eller annen dialog med innringere. Prosjektets vurdering var at ettersom grenseflaten mot publikum ikke er endret ved SAMLOK (de ringer fortsatt de samme numre, og kommer til den enkelte etats sentral) ville det være lite å hente ved å gjøre brukerundersøkelse mot publikum.

Det kan imidlertid være en tanke at en slik undersøkelse gjøres nå for å danne base-line for piloteringen av felles nødnummer, men dette faller utenfor dette prosjektets rammer.

Begrepet «brukere» ble definert som ansatte i nødetatene (brann/redning, politi og helse) i sentralens nedslagsfelt. Det ble valgt å avgrense utvalget innenfor Buskerud fylke, og bare inkludere nødetater som sokner til SAMLOK. Det ble dermed ikke gjennomført intervjuer av politi i Nordre Buskerud politidistrikt, som har tilhørighet til 112 sentralen på Hønefoss eller til brannvesen i Telemark, som er terminert til Telemark 110 – sentral, lokalisert til Skien

Intervjuer med ansatte ved sentralene og ved nødetatene ble gjennomført i form av fastsatt mal, med åpning for frie kommentarer. Det var utarbeidet intervjumal med faste spørsmål, i tillegg ble det åpnet for at intervjuobjektene kom med tilleggskommentarer i form av fritekst.

I spørsmål som omhandlet vurderinger, for eksempel angivelse av kvalitet på trippelvarsling, ble det gitt svaralternativene «god», «middels» og «dårlig». I en del tilfeller anga intervjuobjektet at svaret ville være personavhengig, avhengig av hvem som er på vakt på sentralen. Disse svarene ble det valgt å gi kategorien «middels».

For så langt som mulig å sikre at intervjuene ble gjennomført på samme måte i alle tilfeller, deltok prosjektleder i samtlige intervjuer. DSB deltok på samtlige intervjuer med brann og rednings ansatte utenfor 110-sentralen.

Innledningsvis i hvert intervju ble det presisert at informasjonen ville bli behandlet anonymt, og at originalfilene med navn og referat fra intervjuet vil bli slettet når prosjektet er fullført.

Det ble invitert til møte med tillitsvalgte for å orientere om prosjektet og prosessen. Bare en tillitsvalgt møtte opp. Han gjennomgikk intervju, og hadde ingen merknader til den valgte fremgangsmåten.

De ansatte, både ved SAMLOK og i de enkelte nødetatene, har vært svært velvillige i forhold til intervjusituasjonen og delt sine kunnskaper og synspunkter med oss på en veldig positiv og nyttig måte. Uten dette ville det ikke ha vært mulig å gjennomføre prosjektet, særlig med bakgrunn i at tilgjengelige virksomhetsdata er begrensede. Det var imidlertid til dels utfordrende å få gjennomført

intervjuer med ansatte utenfor SAMLOK. Dette skyldtes på ingen måte uvilje, men dels måtte noen intervjuer avbrytes i prosessen på grunn av oppdrag, dels var det vanskelig å få til intervjuer fordi ansatte ikke hadde mulighet for å gå fra arbeidsoppgavene sine.

Tabell 2. Antall intervjuede.

	SAMLOK	EKSTERNT
Brann og redning	5	9
Politi	8	4
Helse	9	21

Som man vil se er tallene for politi utenfor sentralene og brann og redning i sentralene så vidt lave at det er begrenset hvor sikre slutninger man kan trekke på bakgrunn av dem.

I etterkant av intervjuene ble det gjennomført samtaler med lederne for hver enkelt sentral.

4.3.3. Teknisk gjennomgang

For å få avklart hvilke tekniske systemer som er i bruk ved SAMLOK ble det foretatt intervjuer med teknisk personell tilknyttet hver etat. Følgende personer er intervjuet:

- Mathias Bøhn Grytemark, Brann og redning
- Terje Pettersen, Helse
- Magne Østhus, Politi
- Trond Helland, DNK

Intervjuene ble gjennomført 6. november 2012 i SAMLOKs lokaler, og rapporten omhandler forholdene slik de var på dette tidspunktet.

På forhånd var det blitt utarbeidet skjema som ble benyttet til en strukturert innsamling av data. Det ble i tillegg stilt åpne spørsmål med et ønske om å grave dypere innenfor området som ble oppfattet som spesielt interessant. Følgende kategorier ble brukt for å kategorisere det tekniske utstyret:

- Infrastruktur
- Støttesystemer
- Kommunikasjonssentralløsningen / Nødnett
- Annet

Den tekniske rapporten har vært gjennomgått av prosjektgruppen.

Funnene er presentert i kapittel 4.3.

5. Funn

Funnene fra prosjektet presenteres i ulike deler – operasjonelle funn, funn vurdert opp mot målbeskrivelsen og teknisk samordning. Kanskje viktigst er de rent operative funnene, f.eks. konsekvensene av at sentralene har ulike geografiske nedslagsfelt.

I løpet av den tiden SAMLOK har eksistert har det skjedd vesentlige endringer i nødmeldetjenesten og dens rammevilkår. Noen av disse endringene er blitt sett på i forhold til hvilken innvirkning de kan ha hatt på SAMLOK-prosjektet.

5.1. Operasjonelle funn

5.1.1. Felles gjensidig forståelse

Det går igjen i svært mange av intervjuene, og også av uformelle samtaler vi har hatt med de ansatte i sentralene, at SAMLOK har ført til bedre forståelse av de andre etatenes arbeidsmåter, rammevilkår og måtene aktivitetene gjennomføres på. Dette fremheves av flere som kanskje den mest vesentlige gevinsten ved SAMLOK, og oppleves som svært positiv og utviklende.

5.1.2. Geografisk nedslagsfelt

Mens politiets operasjonssentral dekker Søndre Buskerud politidistrikt dekker AMK i grove trekk Buskerud fylke mens 110-sentralen til brann/ redning dekker hele Buskerud og Vestfold. Befolkningstallene i disse områdene er henholdsvis 212 000 for politiet, 316 000 for AMK og 517 000 for brann/ redning. Mens politiet utelukkende forholder seg til de andre sentralene innenfor SAMLOK, må AMK og i enda større grad brann/redning forholde seg til flere sentraler fra de andre etatene. Dette innebærer at brann/redning og helse fortsatt må forholde seg til sentraler som de ikke er samlokalisert med. Det er et gjennomgående funn at dette medfører en form for todeling av forholdet til andre etaters sentraler, med et vesentlig nærmere forhold til de sentralene man er samlokalisert med.

Intervjuobjektene påpeker at det er en utfordring at de samlokaliserte sentralene har ulike geografiske områder. Det er en sterk tendens til at man samarbeider nært med de sentralene man er samlokalisert med, mens andre sentraler kanskje blir enda fjernere enn de var før SAMLOK.

Gjörv-kommisjonen påpeker også dette med ulike geografiske nedslagsfelt i sin rapport om terroranslaget mot Utøya.

Dette kompliseres ytterligere av at det benyttes ulike radiosystemer (Nødnett/ etatenes gamle analoge nett). Mens Nødnett dekker området Søndre Buskerud, dekkes øvrige deler av SAMLOKs nedslagsfelt av etatenes tradisjonelle analoge nett.. Dette er imidlertid et problem som vil løse seg etterhvert som Nødnett rulles ut videre.

En klar konklusjon er at det er vesentlig når man samlokaliserte sentraler at disse har samme geografiske nedslagsfelt.

5.1.3. Sentralenes lokalkunnskap

Vi har stilt spørsmål til brukerne av nødmeldesentralene om hvordan de opplever sentralenes lokalkunnskap. Flertallet av de spurte innenfor brann/redning og helse mener at sentralenes lokalkunnskap er middels. Mens flertallet av de spurte fra brann/redning mener kunnskapen er blitt bedre etter SAMLOK, mener de fleste fra helsetjenesten at det ikke har vært noen endring. For politiet er det en noenlunde jevn spredning av de spurte mellom de tre mulige svaralternativene, men her er tallene små.

Sammenfallende i tid med SAMLOK ble det gjennomført betydelige endringer for brann/ redning, ved at både sentralens geografiske område og bemanningen i sentralen ble øket. Rekrutteringen til 110-sentralen har forskjøvet seg i retning av deltidsbrannvesen. Dette kan ha medført en noe større geografisk spredning av rekrutteringen. Det har imidlertid blitt understreket i flere intervjuer av ansatte ved brannvesen rundt i fylket at de vanligvis ikke ser lokalkunnskapen ved 110-sentralen som en kritisk faktor, selv om det har vært enkelttilfeller, særlig i områder utenfor Søndre Buskerud, hvor sentralens mangel på lokalkunnskap har hatt innvirkning på hendelseshåndteringen.

Den teknologiske utvikling i form av nye gode elektroniske kartløsninger har medført mindre avhengighet av sentralenes lokalkunnskap. Likevel påpeker flere intervjuede at det er en fordel at man i sentralene har operatører med bakgrunn fra ulike deler av nedslagsfeltet, slik at de kan bistå på tvers av etatsgrensene i sentralene når det er hendelser i deres lokalmiljø. Inntrykket utenfor sentralene er at SAMLOK har bidradd til en bedring her, og at man trekker på hverandres ressurser når det er nyttig og nødvendig.

5.1.4. Trippelvarsling

Trippelvarsling innebærer at den sentralen som primært mottar alarmtelefon kontakter de to andre sentralene slik at de kan settes i medlytt og eventuelt utalarmere egne ressurser. Trippelvarsling brukes ved større hendelser, og hendelser der det er behov for innsats fra mer enn en nødetat. Eksempler er husbrann og trafikkulykker.

Det er flere utfordringer knyttet til trippelvarsling:

- Operatøren må forstå at det er hensiktsmessig med innsats fra flere nødetater.
- Trippelvarslingen må skje så tidlig som mulig for å sikre samhandling fra starten av
- De tekniske forutsetningene for trippelvarsling må fungere.
- «Mottakende» sentraler må ha tilgjengelig personell som varsler egne ressurser

Sentralene i SAMLOK har lagt betydelig innsats i å bedre kvaliteten på trippelvarsling. Fra brann og redning i Drammen påpekes at mens man tidligere ofte hørte ambulansen passere brannstasjonen før man mottok trippelvarsling, er situasjonen nå at trippelvarsling som regel skjer på et vesentlig tidligere tidspunkt.

På spørsmål i sentralene om man oppfatter trippelvarslingen som «God», «Middels» eller «Dårlig» svarer et knapt flertall av de ansatte ved brann/ redning «God», nesten like mange «Middels» og et lite mindretall «Dårlig». I politiet angir et knapt flertall «Middels», et knapt mindretall «God» og igjen et lite mindretall «Dårlig». For AMK-sentralen er tallene tilsvarende som for brann/redning.

For brann/redning og helse er tilbakemeldingen at trippelvarsling fungerer bedre innenfor det geografiske området til Søndre Buskerud enn i resten av fylket. Mens de aller fleste er enige om at trippelvarsling utenfor Søndre Buskerud ikke er endret i SAMLOK-perioden (et mindretall i AMK mener at den har blitt bedre), er det omtrent like mange som mener at trippelvarslingen er blitt bedre, som det er som mener at den er uendret, for Søndre Buskerud.

Blant ansatte utenfor sentralene er situasjonen at et flertall i politi og helse mener at trippelvarsling fungerer godt, mens det for brann/redning er en mer jevn fordeling med et lite flertall som mener trippelvarslingen er «Middels».

Mens det for brann/ redning og politi er like mange som mener at trippelvarsling, innenfor området som tilhører Søndre Buskerud, er uendret eller bedre etter SAMLOK, er det et flertall av ansatte ved utenfor AMK som mener den er blitt bedre etter SAMLOK.

Som en kuriositet kan nevnes at noen av intervjuobjektene innenfor helse opplyser at trippelvarslingen er dårligere når det er brann/redning som er blitt oppringt først, mens det fra brann/ rednings side sies at kvaliteten er dårligere når det er AMK-sentralen som er blitt oppringt først. Det understrekes at brann/redning trenger mindre omfattende informasjon om hendelsen for å rykke ut enn hva som er tilfelle for helse. Derfor bør trippelvarsling iverksettes så tidlig som mulig, selv om AMK-sentralen trenger mer informasjon for å avgjøre hvilke helseressurser som skal alarmeres.

Det har fremkommet at behovet for trippelvarsling varierer lokalt. I små kommuner med store avstander er man oftere avhengig av at nødetatene samarbeider/overlapper. Dermed er det en forutsetning at terskelen for trippelvarsling er lav. De lokale ressursene vil så vurdere om og hvordan de skal respondere. For eksempel vil politiet ofte ikke ha mulighet til å rykke ut på mindre hendelser, pga. ressursituasjonen.

Det synes klart at samlokaliseringen av sentralene og den økte kontakten som er mellom dem har medført større oppmerksomhet på hverandres virksomhet. Dermed er det rimelig å tro at sentralenes avgjørelse om å iverksette trippelvarsling er bedre fundert enn tidligere.

Der er imidlertid klart, i alle fall for de som arbeider utenfor sentralene, at Nødnett har hatt en betydelig effekt i forhold til å bedre kvaliteten på trippelvarslingen og dermed utalarming/ mobilisering av ressurser.

5.1.5. Grad av samhandling i SAMLOK

Vi har gjennom prosjektarbeidet kunnet fastslå at SAMLOK har ført til nærmere kontakt mellom de ansatte ved de tre sentralene. Det er imidlertid tydelig at denne kontakten har sine begrensninger. Selv om sentralene ligger i samme etasje med dører mellom, fremstår de helt klart som tre separate sentraler. Dette gjenspeiles i ulike faglige prosedyrer, og ved at teknologien i begrenset grad er felles.

De fleste av dem som har vært intervjuet, og som har sin arbeidsplass utenfor sentralene gir inntrykk av at de opplever at sentralene samhandler greit, særlig innenfor Søndre Buskerud politidistrikt. Utenfor dette området oppleves også at sentralene for så vidt samhandler stort sett greit, men der er det utfordringer ved at sambandet til nødmeldesentralene ikke fungerer like godt.

5.1.6. Støtte fra sentralene under aksjoner

Operativt personell utenfor sentralene ble spurt om hvordan de opplever den støtten de får fra sentralene under hendelseshåndtering.

Samtlige intervjuobjekter fra brann/redning oppga at de opplevde støtten som god, 75 % mente den var blitt bedre i SAMLOK-perioden. Bedringen tilskrives dels Nødnett, men også at sentralen er blitt mer profesjonell enn tidligere, delvis på grunn av øket bemanning som gir bedre mulighet for oppfølging av hendelser.

For politiet opplevde 3 av de 4 intervjuede at støtten var god, en mente den var middels. 3 av 4 mente situasjonen var uendret i forhold til før SAMLOK, 1 mente den var bedret.

For helsetjenesten er bildet mer sammensatt. Av de 15 som uttalte seg sa 6 at støtten var god, 7 at den var middels og 2 at den var dårlig. På spørsmål om tjenesten er blitt bedre eller dårligere i løpet av SAMLOK svarer 5 at den er blitt bedre, 3 at den er blitt dårligere mens 6 er usikre. Disse funnene ble fulgt opp i «fritekstdelen» av intervjuene. En faktor hos dem som mener tjenesten er middels/dårlig er dårlig fungerende kommunikasjonssystem. Det analoge helseradionettet er enda i bruk i Nordre Buskerud. Helseradioen har tilsynelatende aldri virket veldig godt i Buskerud. Utstyret er nå gammelt og blir ikke erstattet så raskt som ønskelig. Flere ambulansearbeidere fortalte historier om dårlig dekning, dårlig signalering og at kommunikasjonen dermed var ufullstendig, noe som i sin tur førte til at man ikke mottok den tjenesten fra AMK man ville forvente.

5.1.7. Sentralenes forståelse for arbeidsforholdene ute i tjenestene.

For at publikum skal få optimale tjenester er det nødvendig at de ulike leddene i kjeden samhandler, og har forståelse for hverandres oppgaver og rammevilkår. Dette var en vesentlig del av begrunnelsen for SAMLOK, og det var ønskelig å se på i hvilken grad dette har manifestert seg i forholdet mellom sentralene og øvrige tjenester.

Mens de alt overveiende tilbakemeldingene fra brann/redning og politi er at man opplever sentralenes forståelse som god, er bildet mer sammensatt for AMK. Det hevdes at sentralen h i noen tilfeller ber om informasjon fra skadestedet mens ambulansepersonellet har mer enn nok med å behandle pasienten. Det har vært utskifting i personell ved AMK-sentralen, i stor grad som et generasjonsskifte ved at operatører har gått av for aldersgrensen.

Det er ulike synspunkter mellom etatene. Innenfor brann/redning mener et flertall at det har vært en bedring i løpet av SAMLOK. For politiet er svarene mer varierte, mens det store flertall av de spurte i helsetjenesten mener at situasjonen ikke har blitt endret i den aktuelle tidsperioden. På et mer overordnet plan etterlyses samarbeid med tjenestene utenfor sentralen når det fattes bestemmelser om endringer som har implikasjoner for dem. Det er av noen intervjuobjekter gitt uttrykk for ønske om sterkere samhandling på planleggings- og strateginivå.

Det er vanskelig å konkludere i forhold til brann/ redning om endringens skyldes det at sentralene er blitt samlokaliserte, eller om den skyldes at bemanningen i sentralen er blitt utvidet på grunn av større oppdragsmengde.

5.1.8. Samhandling lokale ressurser

På spørsmål om hvordan samhandling mellom nødetatene på lokalt plan fungerer, svarer 79 % av de spurte at det fungerer godt, 14 % at det fungerer middels godt og 7 % at det fungerer dårlig. 62 % mener at samarbeidet er uendret i løpet av tiden SAMLOK har fungert, 29 % at det har blitt bedre. Nødnett blir her påpekt som en vesentlig faktor.

5.2. Resultater av SAMLOK i forhold til prosjektets målbeskrivelse

De ønskede mål for SAMLOK er omtalt i kapittel 2.1. Disse er blitt tatt som et av utgangspunktene for evalueringsarbeidet.

5.2.1. Ansatte

«Et utviklende arbeidsmiljø, som bygger på gjensidig respekt for hverandres kultur og verdier.»

De ansattes arbeidsmiljø er viet betydelig oppmerksomhet i SAMLOK. Både politi og helse holdt til i lokaler som var preget av liten plass og dårlig ventilasjon. Lokalene som nå benyttes er godt tilpasset virksomheten, med gode lysforhold, tilfredsstillende støyskjerming og god adkomst for funksjonshemmede.

Sykefravær er en faktor som ofte ses som en indirekte faktor på arbeidsmiljø. Nødmeldesentralene i Drammen er så vidt små enheter at tallene vil være upålitelig; en eller to personer på langtidssykemelding vil føre til betydelige endringer. For alle tre sentraler gjelder at sykefraværet er lavt. Politiet har ikke separat statistikk for sykefravær ved operasjonsrommet, men angir en generell sykefraværprosent på rundt 3 %, mens tallet for brann/redninger 2 % utenom langtidssykemeldt. Lederne i SAMLOK forteller at operatørene gjennomgående er svært pliktoppfyllende, og kommer på jobb selv om de egentlig burde være hjemme pga. sykdom. AMK hadde 50 % nedgang i sykmeldinger mellom 2008 og 2011, men ser nå en liten økning.

Det er ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt SAMLOK har hatt effekt på gjennomtrekk av personell i sentralene.

Politiet har ikke hatt noen personellutskifting i operasjonsrommet i løpet av SAMLOK, bortsett fra i en hospiteringsstilling der varigheten er begrenset til 6 mnd.

Brann/redning har hatt en økning fra 10 til 15 ansatte grunnet større geografisk nedslagsfelt og økt oppdragsmengde. Det har også vært en del utskifting i forbindelse med oppnådd pensjonsalder. Rekruttering er en utfordring ved at man ønsker å rekruttere personell med erfaring fra brann og redning, og da konkurrerer de med tjeneste i første linje i brannvesen. En vesentlig faktor her er forskjellen i pensjonsalder mellom sentralen og førstelinjetjeneste, noe som fører til at det er vanskelig å få ansatte med erfaring fra heltidsbrannvesen. Man får imidlertid søkere fra deltidsbrannvesen. Disse vil typisk ha sin hovedstilling i annen virksomhet med vanlig pensjonsalder, og har dermed ikke noe å «tape» ved å begynne i sentralen. På den andre siden vil disse typisk ikke ha like utbredt praktisk erfaring som personer som har arbeidet over lengre tid i et fulltids

brannvesen. Man har også rekruttert medarbeidere fra andre sentraler, noe som ses som et tegn på at det er attraktivt å arbeide i SAMLOK. Ulikheten mellom etatene er blitt klarere ved SAMLOK; ettersom politiets mannskap i operasjonssentralen har samme pensjonsalder som politiet for øvrig. For AMK-sentralen har dette ikke fremkommet som noe problem.

Ved AMK-sentralen har det vært noe utskifting. Noen slutter fordi de når pensjonsalderen, andre ønsker å arbeide nærmere pasientene. Det er problemer med å rekruttere ambulansekoordinatorer fordi man konkurrerer med stillinger i ambulansetjenesten. I ambulansetjenesten har man lengre skift, og dermed også mer sammenhengende fritid. Generelt har man imidlertid nå flere søkere til ledige stillinger i AMK enn man hadde før.

Det er ikke gjort felles arbeidsmiljøundersøkelser i sentralene som inngår i SAMLOK. Det ble gjennomført en generell arbeidsmiljøundersøkelse i Søndre Buskerud politidistrikt i 2011. Helseforetaket gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse tidligere i 2012. Det er ikke utarbeidet noe resyme over funnene ved AMK-sentralen som kan offentliggjøres.

I intervjuene er det ikke direkte stilt spørsmål om gjensidig respekt, men mange av intervjuobjektene fremholder nettopp det som en vesentlig gevinst ved SAMLOK. Man har fått innsikt i hverandres arbeidsmåter og rammer. Dette manifesterer seg særlig når de er innringere som har behov for bistand fra mer enn en etat. Operatøren som håndterer henvendelsen har en bedre forståelse for hva de øvrige etatene trenger av informasjon, og er i stand til å stille mer relevante spørsmål i forhold til det.

Mens det tidligere har vært problemer med de ulike bestemmelsene etatene har i forhold til taushetsplikt, mener de fleste intervjuede at dette nå ikke lenger er en begrensning. Politi og brann/redning kjenner godt til hva helsetjenesten kan og ikke kan informere om, og aksepterer disse begrensningene. Det har vært en viss bekymring for at den nære kontakten mellom sentralene kunne føre til lekkasjer av informasjon, men det har ikke fremkommet informasjon om at det har vært tilfeller der en av etatene har gått utover det som er bestemt i forhold til taushetsplikt. Det er utarbeidet en taushetserklæring som er undertegnet av alle som arbeider i SAMLOK.

Noen av de intervjuede har spontant nevnt at det hadde vært lettere å få til uformelt samarbeid innad i SAMLOK dersom man hadde felles lunsj/ hvilerom i tilslutning til sentralene. Andre påpeker at arbeidsbyrden er slik at det i alle fall ville vært svært begrenset hvor mye man ville kunne benytte seg av et slikt tilbud.

Flere av de intervjuede fremholder at det er en vesentlig suksessfaktor at SAMLOK helt fra starten var meget godt forankret på grunnplanen i organisasjonen ved at operatørene var sterkt medvirkende i prosjektet. Noen uttrykker med bekymring at det planlagte prosjektet om felles nødnummer og felles nødmeldesentral ikke på langt nær er like godt forankret på det nivået.

For å få en generell oversikt over hvordan de ansatte i sentralene opplever sitt arbeidsmiljø ble de bedt om å karakterisere samhandlingen internt i sentralen der de arbeider som god, middels eller dårlig.

Samtlige 8 intervjuobjekter i 112 sentralen klassifiserte den interne samhandlingen som god. 5 av dem mente den var blitt bedre etter SAMLOK, de øvrige hadde ikke mening om det (noen av dem var ansatt etter SAMLOK).

På brannsidene angir 4 av 5 at samhandlingen er god, den siste karakteriserer den som middels.

I AMK-sentralen mener 4 de intervjuede at samhandlingen er god, 5 at den er middels. 1 person mener at samhandlingen var bedre før, 4 at den er uendret, 2 at den er bedre nå, mens en person ikke kan avgi noe svar på dette spørsmålet.

Det generelle inntrykket er at målet om et bedret arbeidsmiljø med økt forståelse for andre etaters virksomhet er oppnådd. Det synes klart at det fysiske arbeidsmiljøet er bedret, men også andre faktorer synes å ha utviklet seg positivt. Det ligger imidlertid fortsatt et potensiale før situasjonen kan sies å være perfekt, kanskje særlig for AMK-sentralen.

5.2.2. Økonomi

«Optimalisert ressursutnyttelse gjennom standardiserte og samordnende driftsløsninger.»

Mens brann/ rednings sentral var skilt ut som egen enhet allerede før SAMLOK, hadde politi og helse sine sentraler plassert i henholdsvis Drammen politistasjon og Drammen sykehus. Dette innebærer at det for dem ikke er mulig å finne tall for driftskostnader. Utgifter som arealleie, oppvarming etc. er ikke spesifisert for sentralene, men inngår i driften av henholdsvis politistasjonen og sykehuset.

I og med at tekniske samordninger bare i veldig begrenset grad har blitt gjennomført, har man ikke oppnådd noen stordriftsfordeler her. På den andre siden har man heller ikke hatt investeringskostnader til å utvikle og tilpasse felles systemer.

Tallene man har for arealleie i SAMLOK er heller ikke fullt ut dekkende og overførbare til andre eventuelle prosjekter. Dette skyldes at man i tilknytning til sentralene har flere møterom som ikke er regnet med i arealregnskapet, men som i praksis stilles fritt til rådighet av Søndre Buskerud politidistrikt.

5.2.3. Innovasjon

«Nytenkende og utviklende hva angår samarbeidsform og felles tekniske løsninger.»

I prosjektet hadde man en ambisjon om at samlokalisering og samarbeid skulle føre til nytenkning og utvikling. Mens kontakten mellom sentralene og deres ansatte er blitt vesentlig bedre enn før, er det vanskelig å avdekke at det er gjort veldig mye målrettet utviklingsarbeid. Man har utvekslet noen prosedyrer, og fått bedre forståelse for hverandres arbeidsform. Dette har ført til endringer ved at alle de tre sentralene nå har ansatte med spesielt ansvar for fagutvikling, og man har laget en felles prosedyre for utspørring av innringere ved trafikkulykker. Utover det har lite skjedd i form av innovasjon ved sentralene i Drammen.

Ettersom både politi og brann/redning har uniformerte operatører, har man utviklet uniformer for de ansatte ved AMK. Dette hevdes å ha medført en strammere og mer representativ funksjon, en positiv form for «merkevarebygging».

Det påpekes av flere av dem som er blitt intervjuet at man i en travel hverdag ikke har funnet tid til å drive utviklingsarbeid utover det som kreves i det daglige og det som var krevet for å kunne ta i bruk Nødnett og de nye systemene på sentralene. En annen faktor er at oppmerksomheten nå i stor grad er rettet mot den forestående piloteringen av felles nødnummer, og dette har påvirket aktiviteten i SAMLOK.

5.2.4. Samarbeid:

«Bidra til at nødmeldetjenesten kan utvikles gjennom samarbeid intern og eksternt».

Det er i prosjektdirektivet lagt vekt på at SAMLOK skal føre til økt samarbeid mellom etatene. At dette har skjedd på sentralt nivå går igjen som et funn i de aller fleste intervjuene som er gjort med personell ved sentralene. Det at man ses til daglig, og kjenner dem som sitter på de andre sentralene, har medført at man i større grad enn før konfererer i løpet av håndteringen av en hendelse. Et eksempel som går igjen i intervjuene er at når en sentral får melding om en hyperakutt hendelse (f.eks. når personer har ramlet i vannet), gis det øyeblikkelig beskjed «i døren» til de andre sentralene som så setter i gang mobilisering av sine ressurser. Det har imidlertid vist seg at denne kommunikasjonsformen har en svakhet i forhold til at tidspunkt for varsling av annen sentral ikke blir logget, så det er nå innført som en fast regel at meldingen også går via telefon som lydlogges.

Ansatte i alle sentralene understreker at SAMLOK har hatt positiv innvirkning på forståelsen sentralene i mellom. Man har fått bedre forståelse for hverandres oppgaver og løsningen av disse. Et eksempel er at man har oppnådd felles forståelse av taushetsplikten.

Før SAMLOK var det bare AMK-sentralen som hadde egen stilling for fagutvikler, nå har alle sentralene opprettet slike stillinger. Disse har som oppgave å stå for den faglige og operative videreutviklingen av sentralene. Fagutviklerne arbeider tett sammen om utvikling på de områdene der dette er relevant, noe som i sin tur fører til bedret samhandling i felles aksjoner. Et eksempel er at flere operatører har deltatt i kurs om samhandling på skadested.

Det arrangeres felles fagdager for operatørene ved alle sentralene. Her dekkes temaer som er felles for etatene, og det utveksles erfaringer og kunnskap.

Mens politiet i forkant hadde operativ leder i sentralen, var strukturen i de andre sentralene mer flat. Nå har både 110-sentralen og AMK etablert en tilsvarende struktur.

Prosjektbeskrivelsen inneholder et avsnitt om at man ønsket å etablere sosiale fora for å sikre samhørigheten innen SAMLOK. Dette har vist seg å være en suksessfaktor i forhold til å skape nettverk mellom operatørene på de ulike sentralene.

Der er et felles styre for SAMLOK, der representanter for de tre etatene møtes. Organisasjonsformen for de tre sentralene er ulik. Mens sentralene til politi og helse er del av henholdsvis Drammen politidistrikt og Drammen sykehus, er 110-sentralen skilt ut som et eget interkommunalt selskap, eid av kommunene sentralen dekker.

På ledernivå har man regelmessige møter der saker av felles interesse for de ulike sentralene tas opp. Dette samarbeidet er vesentlig og fungerer godt.

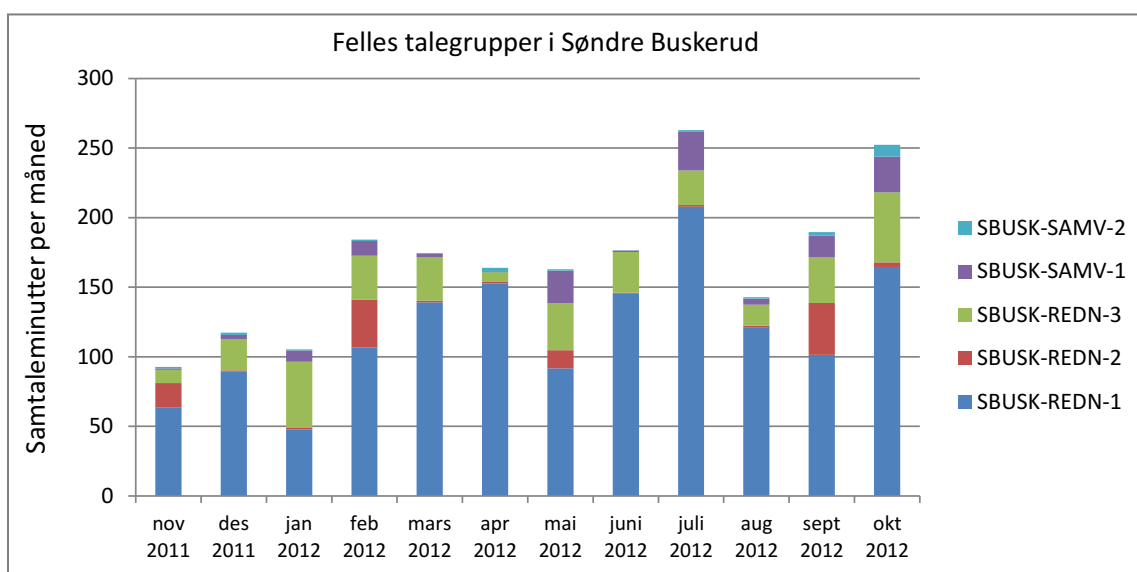
Det har vært nevnt av flere av dem som er blitt intervjuet at operatørene opplever at de har to funksjoner. På den ene siden er de fagfolk innenfor sine fagfelt (sykepleiere, brannfolk, politifolk) og på den andre siden er de profesjonelle telefonoperatører som i varierende grad mobiliserer og koordinerer etatenes ressurser. Det har vært understreket av mange av dem som er blitt intervjuet at de ser det som helt vesentlig at de som svarer nødansrop har en profesjonell bakgrunn innen for det aktuelle området. Dette er vesentlig i forhold til å kunne veilede innringer innenfor de ulike fagområdene, i tillegg til å kunne sikre at relevant informasjon kommuniseres så vel fra innringer til sentralen som den andre veien. Det er imidlertid ikke full enighet om at alle som arbeider ved sentralene trenger slik bakgrunn, men den fagkompetansen må være til stede til enhver tid.

Når det gjelder rollen som telefonoperatør/koordinator, så har denne fellestrekk mellom de ulike etatene, og for denne delen av arbeidet ved sentralene er det gjort noe felles arbeid. Et eksempel er at man har hatt en gjennomgang av når og hvordan man gjennomfører trippelvarsling. Det er bred enighet både blant dem som arbeider på sentralene og i tjenestene utenfor om at det her er blitt en vesentlig bedring, selv om det enda er uutnyttet potensiale.

Det er en gjennomgående vurdering fra de intervjuedes side at SAMLOK har ført til økt samarbeid mellom etatene. Samarbeidet mellom sentralene under hendelseshåndtering går på flere plan. Det angis som vanlig at man konsulterer hverandre ved behov. Det økte kjennskap til de andre etatene har ført til bedre kunnskap om muligheter og begrensninger. Det ble nevnt at dette medfører at man nå ber om bistand i saker der man tidligere ikke visste at f.eks. brannvesenet har utstyr som kan være nyttig i ulike sammenhenger.

Det fremkommer i mange av intervjuene at man i de områdene som har fått Nødnett benytter Redning 1 i vesentlig grad under utrykninger og hendelseshåndtering. Dette innebærer at etatene har samme informasjonsgrunnlag tidlig i hendelseshåndteringen, og også har mulighet for bedre informasjonsutveksling videre. Dette ses på som svært positivt. Det hevdes av flere at SAMLOK har medført økt oppmerksomhet på dette området.

Figur 2. Bruk av felles talegrupper i Søndre Buskerud. Kilde: DNK.



Som det fremgår av figuren synes trenden å være at det er en økende bruk av felles talegrupper i Søndre Buskerud.

Ved større hendelser har det blitt vanlig at operasjonslederne ved de enkelte sentralene møtes i møterom like utenfor sentralen og legger en felles strategi for hvordan hendelsen skal håndteres, hvilke tiltak som skal iverksettes etc. Dette oppleves som meget nyttig og ville ikke vært praktisk mulig uten at sentralene var samlokaliserte.

Politiet har mer utviklet kultur for debriefing enn de andre etatene. Etter SAMLOK har det blitt vanlig at politiet inviterer helse og brann/redning til felles debriefing. Dette ses på som svært positivt av alle tre etater.

Før SAMLOK var sentralene fysisk plassert på henholdsvis Drammen brannstasjon, Drammen sykehus og nærmere de øvrige operative enhetene på politistasjonen. Det ble i intervjuene fokusert på om denne flyttingen hadde medført svekket kontakt og samarbeid med egen etat.

Helsetjenesten skiller seg fra de andre etatene ved at ressurser fra hele dekningsområdet fra tid til annen er i Drammen på oppdrag. Dette gjelder særlig ambulansetjenesten, som fra hele distriktet frakter pasienter til sykehuset i Drammen. AMK-sentralen var plassert like ved akuttmottaket, så det var vanlig at ambulansarbeiderne stakk innom og tok en kopp kaffe når de var der. Dette medførte at de kjente dem som satt i sentralen, og hadde mulighet til å diskutere så vel enkelttilfeller som mer generelle temaer. Dette er betydelig vanskeligere med SAMLOK. Det påpekes at det er vanskeligere å ta den ekstra turen til politistasjonen, nærmest umulig å finne parkering, og dessuten må man belaste sentralens personell med at de må sørge for å få de besøkende forbi låst dør. Det at det er tilgangskontroll oppfattes som lite gunstig av ambulansepersonellet.

Operatørene ved AMK-sentralen bekrefter at kontakten er blitt mindre enn før. Det er imidlertid litt delte synspunkter på i hvilken grad dette er positivt eller negativt. Det er enighet om at den personlige kjennskapen er blitt mindre, og at man har mindre løpende kontakt utenom det som går via radio/telefon om den enkelte hendelsen. På den andre siden påpeker flere av operatørene at det er en fordel at man nå får arbeidsro. Noen nevner også at det var en utfordring å håndtere større hendelser i den gamle sentralen, fordi det tenderte til å være mange som oppsøkte sentralen for å få løpende oversikt over hendelseshåndteringen.

Fra sykehuset i Drammen ble det også kommentert på at kontakten nå er mindre enn den var før. Derfra ble det imidlertid nevnt som positivt at forholdet mellom mottakelse og AMK nå er mer formalisert, ved at man har måttet lage prosedyrer for det man før «bare gjorde». Dette betyr at tjenesten i akuttmottaket er blitt bedre ved at det er større sikkerhet for at ting blir gjort, og dokumentert. Kongsberg sykehus bekrefter det meste som er sagt fra Drammen, men legger til at prosedyrene for å komme seg inn på sentralen er et vesentlig hinder for personlige, uformelle, møter. Man opplever også at sentralen nå oppleves som mer profesjonell enn tidligere, men vet ikke om dette kan tilskrives SAMLOK.

For brann/redning har samlokaliseringen falt sammen i tid med at man utvidet nedslagsfeltet i betydelig grad. Dermed har man også utvidet bemanningen fra to til tre personer. Før flytting lå 110-sentralen i Drammen brannstasjon, og utførte noen oppgaver for dem, for eksempel adgangsgangskontroll. De intervjuede operatørene angir at flyttingen har medført mindre kontakt

med Drammen brannvesen, men på den andre siden bedre kontakt med resten av distriktet. Dette beskrives som viktig og riktig, ettersom Drammen før flyttingen var i en særstilling i forhold til andre brannvesen. Det er interessant at de som er intervjuet ved Drammen brannstasjon fullt ut deler denne vurderingen. De påpeker også at forholdet til 110-sentralen har blitt mer profesjonelt, og at utalarmeringen er blitt bedret av at operatørene er blitt mer fokusert på denne delen av oppgavene sine etter at ble kvitt de andre oppgavene de hadde da de var på brannstasjonen.

Felles for brann/ redning og helse er at intervjuobjekter utenfor sentralene ofte uttrykker ønske om at sentralene skulle være mer «utadrettet» og besøke de ulike tjenestene.

Politiet hadde tidligere sitt operasjonsrom lenger nede i bygningen, i nær kontakt med øvrige avdelinger. At de nå er flyttet opp noen etasjer har også for politiet ført til en økt profesjonalisering og at man har måttet formalisere kontaktformene. Et eksempel er at briefingene som hver morgen ble gjort muntlig nå er erstattet av at operasjonsleder lager en PowerPoint presentasjon av siste døgns relevante hendelser som så distribueres til alle politistasjonene. Dette er imidlertid en enveis kommunikasjon, og flere nevner at de savner tilbakemelding fra stasjonene på det som sendes ut på denne måten.

Representanter for alle tre nødetatene, både innenfor og utenfor sentralene, har påpekt at SAMLOK, hvor sentralene er flyttet fra sin svært nære fysiske kontakt med tjenestene til et mer «nøytralt» område, har medført at kontakten med etatene i Drammen nok er blitt noe svakere. Til gjengjeld oppleves det nå at sentralene er flinkere til å se helheten i Buskerud. Dette oppleves som nyttig og riktig, selv om det enda sies å være et stykke igjen til alle enheter i fylket får samme oppmerksomhet.

SAMLOK har medført at de tre etatene har blitt mer synlige. Et eksempel er at Brann/redning nå deltar i fylkesmannens beredskapsutvalg, noe de ikke gjorde før.

På spørsmål om hvordan SAMLOK har påvirket andre deler av nødmeldetjenesten enn de lokale sentralene i Drammen svarer flere at det har vært veldig mange fra andre sentraler rundt om i landet som har vært på besøk ved SAMLOK, og som har gitt uttrykk for at besøket har påvirket deres tankesett. Flere av de besøkende har gitt uttrykk for at de ønsker å arbeide for tilsvarende samlokalisering i andre områder. Særlig fra helsetjenestens side fremholdes at mens SAMLOK innledningsvis var svært kontroversielt mener man å oppleve en dreining mot at flere ser det positive i forhold til utvikling av AMK ved at man har nær kontakt med de andre etatenes sentraler.

Når det gjelder SAMLOKs effekt på videreutvikling av nødmeldetjenesten erkjennes at denne kunne vært større om man hadde vært flinkere til å informere om prosjektet og dets innhold og resultater.

Det gjennomgående inntrykket basert på intervjuer er at samarbeid og samhandling har hatt en positiv utvikling i forbindelse med SAMLOK, og at dette er en pågående trend som kan forventes å utvikles videre.

5.2.5. Kvalitet

«Forbedret tjenestekvalitet til innbyggerne igjennom samhandling og felles rutiner».

En bedring av tjenesten i forhold til innbyggerne/dem som trenger hjelp må være den alt overveiende begrunnelsen for å gjennomføre endringer.

Spørsmålet om tjenestekvalitet for publikum ble tatt opp i mange av intervjuene, men felles for intervjuobjektene var at de på dette området hadde lite faktainformasjon. Konklusjonen er derfor at det i evalueringen ikke har vært mulig å gi noen begrunnet vurdering av om, og i hvilken grad, SAMLOK har medført endret tjenestekvalitet til publikum gjennom samhandling og felles rutiner.

Ulikheter i arbeidsformer gjør at kvalitetskriterier ikke i alle tilfeller kan vektlegges like mye for de ulike etatene. Et eksempel er responstid. Mens helsetjenesten og brann/ rednings ressurser i stor grad er på sine stasjoner når de ikke er aktive, er politiet i større grad ute blant publikum også når det ikke er hendelseshåndtering på gang. Det innebærer at politiets responstid fra telefonhenvendelse til de er på hendelsesstedet vil variere avhengig av hvor patruljene befinner seg når alarmen går.

Det har ikke vært mulig å påvise noen endring i tjenestekvaliteten til befolkningen. Det betyr ikke at en slik endring ikke finnes.

5.3. Teknisk samordning

Hensikten med dette kapitlet er å beskrive hvilke systemer som er delte, hvilke som er separate og i hvilken grad man har spart penger på samlokaliseringen rent teknisk.

Følgende kategorier er brukt for å kategorisere det tekniske utstyret:

- Infrastruktur
- Støttesystemer
- Kommunikasjonssentralløsning / Nødnett
- Annet

5.3.1. De ulike tekniske komponentene

- Nødnettprosjektet med leveranser av nye kommunikasjonssentralløsninger til nødetatene har medført fornyelse av vesentlige deler av utstyret i sentralene. Løsningene gir blant annet nye muligheter for å betjene telefoni og samband. Mens brann og redning i tillegg har fått nytt oppdragshåndteringssystem, har politi og helse fortsatt sine gamle systemer på disse områdene.
- Det antas at utfordringene omkring dette ikke i vesentlig grad er påvirket av SAMLOK per se, men mer en konsekvens av at det ikke har vært mulig å rulle ut Nødnett for områder som for alle etatene faller sammen med de geografiske områdene for enkeltsentraler.
- Felles for sentralene er at de har system for kommunikasjon, kartapplikasjoner, oppdrags/ hendelseshåndteringssystemer og system for dokumentasjon. Ut over de nye kommunikasjonssentralløsningene (som i det store er like for etatene), er det vesentlige ulikheter i hvordan disse systemene er bygget opp, og hvilke leverandører som benyttes, og hvordan systemene anvendes i operativ gjennomføring.

5.3.2. Infrastruktur

- **Stasjonært utstyr tilkoblet fastnett (Server- og klientløsning utenfor Nødnettleveransene)**

Funn: Ingen servere eller klienter er delt mellom etatene. Etatene har valgt tilsynelatende lik struktur på sine IT-løsninger.

Brann og redning: Lokale servere som kjører fagapplikasjoner for Brann. På operatørplassene benyttes vanlige stasjonære PCer. Pc-ene er plassert på teknisk rom. Det er lokal drift på utstyret.

Politi: Lokale servere med stasjonære PCer som klienter. Klientene er plassert på teknisk rom. Politi planlegger redundant tynnklientløsning med driftssentral i Oslo.

Helse: Helse har en noe annen tilnærming enn brann/ redning og politi, ved at man har en fast server med ti virtuelle servere. Serverne fungerer mot en sentralisert server hos Sykehuspartner, men det er et krav at løsningen skal kunne fungere uten nettverksforbindelse mot Sykehuspartner.

- **Mobilt håndholdt utstyr/terminaler (Mobiltelefoner, håndholdt radio, bærbare pc / nettbrett)**

Funn: Mobile terminaler deles ikke mellom etatene. Mulighetene for deling reduseres ved at terminalene er ulikt programmert (f.eks. talegrupper i Nødnett).

Brann og redning: Bruker smarttelefoner med e-post og kalenderfunksjonalitet. Det er ingen fagapplikasjoner på bærbart utstyr.

Politi: Løsningen «mobility» er tilgjengelig for nettbrett og mobiltelefoner.

Helse: AMK-sentralen har to radioer knyttet til helseradionettet. De har dessuten fire bærbare PCer som brukes til Internett.

- **Interne og eksterne, kablede og trådløse nettverk**

Funn: All kabling er gjort i fellesskap. Kabler ligger i felles trekkør/kanaler. Det er felles patchepanel på teknisk rom som administreres i fellesskap. Det er benyttet kabelfarger rød (brann og redning), blå (politi) og grønn for visuelt å vise hva som tilhører hver etat, der det er trukket kabler f.eks. fra svitsjer til patchepanel og på møterommene. Det er i tillegg tre separate trådløse gjestenett. Gjestenettene er rene Internettforbindelser uten tilgang på ansattnett (interne applikasjoner). Det antas at de underliggende innkjøpsavtalene ikke er tilpasset SAMLOK og at trådløst gjestenett har fulgt med i standardleveransen for alle tre etater.

Brann og redning: Kablet ansattnett. Trådløst og kablet gjestenett.

Politi: Kablet ansattnett. Trådløst og kablet gjestenett. Ansattnettet er delt i to der et er operativt nett med tilgang til fagapplikasjoner men ikke Internett, mens administrativt nett kun gir tilgang til Internett.

Helse: Kablet og trådløst ansattnett og gjestenett.

- **Fillagring og utskriftservere**

Funn: Det er ikke noen felles fillagring eller utskriftservere. Det er ikke funnet noen løsninger med fellesskriver som kan tilkobles tre separate ansattnett. Hver etat har dermed sine egne skrivere. Filområdene er separate og det er ikke opprettet noen felles filområder.

Brann og redning: Lokal filserver, med lokal rutine for sikkerhetskopiering.

Politi: Fillagring- og utskriftservere er lokalisert i Oslo. Lokal skriver på operasjonssentralen.

Helse: Fillagring- og utskriftserver er lokalt i en av de virtuelle serverne driftet av Sykehuspartner.

- **Nettverkselektronikk (Svitsjer, rutere og brannmurer)**

Funn: All nettverkselektronikk er adskilt.

Brann og redning: Egen nettverkselektronikk.

Politi: Egen nettverkselektronikk.

Helse: Egen nettverkselektronikk.

- **Bredbånd / Fiber**

Funn: Hver etat har sin leverandør av fiberlinjer inn til teknisk rom. Noen av dem har også redundante fiberlinjer og fiberrutere. Fiberlinjene holdes separate og deles ikke. En fordel med at hver etat har sin leverandør på fiberlinje, er at man kan oppnå redundante løsninger. I en situasjon der én etat skulle miste sin forbindelse må man da være villig til å kunne dele fibertilgang mellom etatene.

Brann og redning: Egen leverandør av fiber.

Politi: Egen leverandør av fiber.

Helse: Egen leverandør av fiber.

- **Periferiutstyr (Skjermer, mus, skrivere, elektroniske tavler og annet)**

Funn: Det er ikke felles innkjøpsavtaler mellom etatene av periferiutstyr og ikke felles lager. Ved behov er etatene gjensidig behjelpelig med utstyr for å avhjelpe et akutt behov.

Brann og redning: Eget lager og innkjøpsrutine.

Politi: Eget lager og innkjøpsrutine.

Helse: Eget lager og innkjøpsrutine.

- **Intranett**

Funn: Det er ikke etablert noe felles Intranett mellom etatene.

Brann og redning: Felles nasjonalt intranett for brannsentralene er etablert og følger utrulling av Nødnett.

Politi: Intranett for politiet nasjonalt er etablert.

Helse: Intranett for Vestre Viken benyttes.

- **Strøm (Strømforsyning og nødstrøm)**

Funn: Det er etablert et felles godt dimensjonert strømanlegg som består av to separate kabler i en kanal på hver side av huset fra Trafokiosk. Sentralene har felles nødstrøm. Politiet innehar avtalene og fordeler kostnader etter fordeling etter antall stillingshjemler og antall disponerte kvadratmeter.

- **Teknisk rom**

Funn: Stort og luftig teknisk rom med mye plass. Det er satt av plass til nye tekniske løsninger for eventuell deling av CCTV. Tre kjøleanlegg, der kun ett benyttes. (to i bakhånd) Separate skap for hver etat. Løsning for tidlig varslings av eventuelt brann og redning.

Brann og redning: Felles teknisk rom.

Politi: Felles teknisk rom.

Helse: Felles teknisk rom.

- **Tilgjengelighet til teknisk rom**

Funn: De tre etatene har organisert rutiner for hvem som har tilgang på teknisk rom.

- **Driftsrutiner, serviceavtaler og teknisk support**

Funn: Det er ikke felles driftsrutiner og serviceavtaler mellom etatene på annet enn strøm til lokalene og kjøling av teknisk rom. Alarm og kortsystem er felles og administreres av IKT-seksjonen, Politiet.

Brann og redning: Telefonsupport til egen lokal teknikk. De har driftsavtaler på noe av utstyret. BDO håndterer support på callsenterutstyret (ICCS fra Frequentis).

Politi: Lokal IKT-avdelingen har vaktordning. PDMT håndterer support på callsenterutstyret (ICCS fra Frequentis).

Helse: Sykehuspartner håndterer teknisk drift og support. Lokal kontaktperson håndterer alt annet som ikke er drift. HDO håndterer support på callsenterutstyret (ICCS fra Frequentis).

- **Videokonferanse**

Funn: Ingen av etatene har videokonferanseutstyr i SAMLOK-lokalene.

- **Video/bilder (CCTV)**

Funn: Det arbeides med å dele video i saker der dette har relevans, men dette er ikke iverksatt per dags dato.

Brann og redning: Video fra vegtrafikksentralen over tuneller og store vegkryss i sitt ansvarsområdet.

Politi: Video fra arrest og inngangsparti (skallsikring).

Helse: Helikopterlandingsplass.

- **Enterprise service bus (ESB)**

Funn: ESB ligger i Frequentisløsningen. Det er ikke benyttet noen form for ESB for å kunne utveksle informasjon på tvers av etatene.

Brann og redning: Brann og redning har valgt å ikke benytte ESB.

Politi: ESB i Frequentisløsningen.

Helse: ESB i Frequentisløsningen.

5.3.3. Støttesystemer

- **Oppdragshåndtering**

Brann og redning: Vision fra Foretek.

Politi: PO (Politioperativ system, egenutviklet ved PDMT).

Helse: AMIS fra Nirvaco AS.

- **Kart og flåtestyring**

Brann og redning: Vision brukes til posisjonering av biler i Nødnett. Kartleverandøren er Norge digitalt. Transfire fra Locus benyttes til posisjonering av biler utenfor Nødnett.

Politi: Kartsystemet i sentralen er Geopol. Her får man oversikt over bilenes posisjon. Locus er leverandør av GPS og GPRS sender/mottaker som er plassert i bilene. Utdarmering gjøres kun ved hjelp av radiosamband og telefoni, det sendes ikke oppdrag til bilene. Bilene har hyllevare kartsystem (Tomtom, Garmin, etc.).

Helse: Transmed fra Locus AS.

- **E-post**

Funn: Det er ikke etablert noen felles e-postkonto til SAM-lok. For alle sentralene gjelder at man har personlige kontoer og en eller felles adresser til de enkelte sentraler.

- **Lydlogg**

Funn: Alle inn- og utgående radio- og fastlinjetelefon samband hos sentralene i SAMLOK blir logget.

- **Rutiner og prosedyresamlinger**

Dette punktet omhandler teknisk deling av eksisterende rutiner og prosedyresamlinger.

Funn: Det er ikke etablert noen tekniske løsninger for deling av eventuelle felles rutiner og prosedyrer.

Brann og redning: Nettside for kommuner og hendelser som viser type respons. Lokal web-basert rutinesamling som kalles indeks.

Politi: Prosedyrer publiserer på Intranettet.

Helse: Bortsett fra for Medisinsk indeks er rutinene tilgjengelige på Intranettet.

- **Prosjektverktøy**

Funn: Det er ikke felles prosjektverktøy. Det blir nevnt at det ikke har vært noen felles prosjekter med de andre samlokaliserte etatene.

Brann og redning: MS Project.

Politi: MS Project.

Helse: Har ikke.

- **Varslingssystemer**

Funn: Etatene benytter ulike systemer for utalarmering/ varsling. Varsling mellom sentralene (tverrvarsling og trippelvarsling) skjer via telefoni (via fastlinjenettet) eller Nødnett.

Brann og redning: Der Nødnett er implementert benyttes dette til utalarmering, for øvrig brukes brannvesenets eget personsøkernett. UMS benyttes til teknisk personell.

Politi: SMS ordning. Det er callinganlegg internt på politihuset.

Helse: Der Nødnett er implementert benyttes dette til utalarmering, for øvrig brukes utalarmering i Helseradionettet.

- **Opprinnelsesmarkering og overføring av A-nummer (Mulighet for overføring)**

Brann og redning: A-nummer blir ikke videreført, men sentralen kan videresende posisjonen fra Transfire til Transmed.

Politi: Samtalen settes over til annen etat og A-nummer leses opp muntlig. Opprinnelsesmarkeringen overføres ikke.

Helse: A-nummer blir ikke videreført, men sentralen kan videresende posisjonen fra Transmed til Transfire.

- **Kontor-applikasjoner**

Funn: Alle etatene bruker Microsoft som leverandør av kontorapplikasjoner.

Brann og redning: Officepakken fra Microsoft. Lisensen administreres lokalt.

Politi: Officepakken fra Microsoft. Lisensene administreres av PDMT.

Helse: Officepakken fra Microsoft. Lisensene administreres av Sykehuspartner.

- **Statistikkverktøy**

Alle etatene har tilgang til statistikkverktøy via ICCS.

Brann og redning: Brann har ikke ytterligere statistikkverktøy utover det som finnes i ICCS.

Politi: Webbasert statistikkløsning, (Politiets analysesystem PAL). Som blant annet henter data fra PO. *Helse:* AMIS rapportverktøy som inneholder en statistikkmodul.

5.3.4. Kommunikasjonssentralløsning levert i Nødnettprosjektet

- **Installasjon**

Funn: Det har ikke vært tilpasning av leveransen i forbindelse med SAMLOK. Dette innebærer at hver etat har fått hver sin separate kommunikasjonsentralløsning fra Frequentis.

Brann og redning: Separat installasjon fra Frequentis.

Politi: Separat installasjon fra Frequentis.

Helse: Separat installasjon fra Frequentis.

- **Overtakelse av annens sentrals funksjoner**

Funn: Ingen avtale om gjensidig overtakelse av en sentrals funksjoner på tvers av etatene.

Brann og redning: Det er en avtale om overføring til ABØ, men det er ikke gjennomført tester for å sikre at dette fungerer.

Politi: Nødtelefonen blir viderekoblet til en annen av politiets operasjonssentraler ved nedetid.

Helse: Gjensidig avtale med AMK Oslo-Akershus.

- **Installasjonskostnad**

Standardkostnaden for Frequentisinstallasjonen var den samme som om de tre etatene

skulle installert denne på hver sine lokasjoner. Det var dermed ingen besparelse på dette området.

- **Feilsøking**

Feilsøking i Frequentisløsningen er tre-delt. Man benytter først lokal kontaktperson, så etatens egen driftsorganisasjon deretter leverandøren (Motorola)

For Frequentis løsningen er det 2 GUI, et for helse, ett for de 2 andre.

Dette kompliserer det at en teknisk ansvarlig kan opptre som lokal kontaktperson for en annen etat, forutsatt at det formelle med en slik stedfortrederrolle er avklart.

5.3.5. Annet

- Felles møterom med teknisk utstyr som Smartboard, LCD og projektorer. Møterommene bestilles ved å føre seg opp i en bok som ligger på møterommene, da det ikke er noen andre tekniske løsninger alle etatene har tilgang til, som for eksempel en delt kalender e.l.
- Felles innkjøp av kopipapir.
- Felles innkjøp av pulter.
- Strøm, vasking, papir til printere og kaffe fordeles etter en "nøkkel".
- I enkelte situasjoner hjelper teknisk personell fra etatene hverandre ved behov.
- I utgangspunktet skulle alle teknikere dele felles kontor (teknikerkontoret). Dette skulle være en area for erfaringsutveksling på tekniske utfordringer mellom etatene. Dette er det ikke blitt noe ut av.

Bygningsmessig er det grunn til å anta at det har vært en besparelse, da det her er tre etater som stiller mye de samme kravene til bygningsmasse.

6. Eksterne faktorer som kan ha påvirket SAMLOK

6.1. Innføring av Nødnett

Implementeringen av SAMLOK falt sammen i tid med innføringen av Nødnett i Søndre Buskerud. Det synes å være en utbredt oppfatning at implementering av Nødnett ikke var en forutsetning for SAMLOK, men det kan ha medført en fremskynding av prosjektet. I Nødnettprosjektet bygges et helt nytt radiosystem for nødetatene, og det gjøres betydelige installasjoner i nødmeldesentralene. Spesielt for brann/redning innebærer leveransen en total omlegging av teknologien ved sentralen ved at man får et fullstendig nytt beslutningsstøttesystem, bestående av oppdragshåndterings-verktøy, nytt kartverk og mottak av automatiske brannalarmer. Også for politi og helse gjennomføres betydelige oppgraderinger i sentralen. Nødnett medfører også viktige endringer, ved at man får tilgang til bedre muligheter for kommunikasjon mellom sentraler og operative enheter, og mellom operative enheter i felt, både mellom enheter fra ulike etater, og innenfor den enkelte etat.

Politiets nødmeldesentral i SAMLOK har Nødnett i hele sitt nedslagsfelt, mens brann/redning og helses sentraler er henvist til både å benytte sine analoge systemer, og Nødnett. Alle som arbeider i disse sentralene og som har kommet inn på dette temaet i intervjuer, påpeker at denne situasjonen er uheldig og til tider svært krevende.

Særlig fra helses del har det vært påpekt at deres analoge nett (helsetjenestens felles, nasjonale radionettverk) generelt fungerer dårlig i Buskerud, og at det er problemer med å vedlikeholde og å anskaffe nytt utstyr i dette nettet.

I intervjuene fremkom at brukerne gjennom gående var svært fornøyde med det nye digitale radiosystemet, Nødnett. Dekningen fremheves som svært god, vesentlig bedre enn de gamle systemene. Noen påpeker at talekvaliteten varierer, men dette regner man med at vil rette seg etter hvert.

Særlig fra brann og redning fremheves det positive i kommunikasjonssentralleveransen i Nødnettprosjektet.

For alle gjelder at man er fornøyd med brukergrensesnittet i kommunikasjonssentralen (også kalt ICCS), med mulighet for å spille av nettopp gjennomførte samtaler etc.

Sentralleveransen innebærer at man får vesentlige bedre muligheter for å hente ut statistikk om oppringninger, f.eks. hvordan trafikken fordeler seg over døgnet/uken og årstiden. Det har tidligere bare vært AMK-sentralene som var i stand til å gi denne informasjonen, og da via beslutningsstøttesystemet (AMIS) heller enn fra telefonisiden.

Det har i løpet av perioden for SAMLOK vært gjort noen oppgraderinger i telefonidelen av de nye kommunikasjonssentralene, og dette har medført at man har mistet statistikk. Det er dermed ikke tilgjengelig statistikk fra første del av perioden, noe som er medvirkende til at det ikke var mulig å foreta sammenlignende studier mellom sentraler innenfor og utenfor det geografiske område som dekkes av SAMLOK.

Flere har påpekt at implementering av Nødnett-leveransene har vært svært ressurskrevende for alle ledd i etatene. Når nå implementeringen er fullført vil det være lettere å gi SAMLOK den oppmerksomheten som skal til for at man kan komme lenger i utviklingen av felles prosedyrer, teknisk samhandling etc.

Det uttales at det hadde vært ønskelig at implementeringen av Nødnett-leveransen kunne vært kjørt som et felles prosjekt for de tre etatene. På tross av SAMLOK og atmosfæren av samarbeidsvilje mellom etatene lot dette seg ikke gjøre. Implementeringen av Nødnett ble tre ulike prosjekter, med separate leveranser for hver etat, og ulike tidspunkter for når sentralene tok Nødnett og deres nye løsninger i operativ bruk.

6.2. Terroraksjonene 22. juli 2011

Utøya ligger innenfor det geografiske området som dekkes av brann/redning og helse i SAMLOK. Etter terrorhandlingen har det vært betydelig oppmerksomhet på nødetatenes håndtering, og dette har medført en gjennomgang av virksomheten. Et resultat er at bemanningen ved operasjonsrommet hos Nordre Buskerud politidistrikt har blitt øket. En vesentlig andel av de som er blitt intervjuet har påpekt at dette har lettet samarbeidet, og at tjenesten har blitt betydelig bedre enn tidligere.

Grundige gjennomganger av terrorhandlingen og dens konsekvenser har også ført til andre endringer som alle har bidratt til å fremme kvaliteten på det arbeidet som gjøres ved sentralene i SAMLOK.

Imidlertid påpekes det at den store interessen og arbeidet med korreksjoner av tjenesten etter 22. juli har bidradd til å ta fokus vekk fra SAMLOK og bidradd til forsinkelse av gjennomføringen.

6.3. Generelle endringer i nødmeldetjenesten

Nødmeldetjenesten er gjenstand for stor oppmerksomhet, både politisk, i media og i befolkningen generelt. De siste årene det vært en til tider opphetet debatt om organiseringen av tjenesten, med forslag om felles nødnummer som et fremtredende innslag. Det er sterke synspunkter på begge sider i denne saken, som ligger utenfor dette prosjektets mandat. Imidlertid er det grunn til å anta at denne debatten, og oppmerksomhet på tjenesten generelt, medfører at tjenesten selv har fokus på kvalitet og organisatoriske forhold. Det er imidlertid vanskelig å fastslå i hvilken grad dette kan påvirke de områdene som er angitt som målområder for SAMLOK.

6.4. Effekter av SAMLOK vs. effekter av eksterne faktorer

Det er en vesentlig utfordring å skille effektene av SAMLOK fra effektene av de eksterne faktorene nevnt over. Særlig på sentralnivå er det en utbredt og tilsynelatende godt begrunnet oppfatning at de eksterne faktorene har påvirket fremdriften av SAMLOK.

På den andre siden har de eksterne faktorene også påvirket virksomheten, ofte i samme retning som det man ville forvente av SAMLOK. Det kanskje mest fremtredende eksemplet er Nødnettprosjektet. Leveransen har foruten et bedret og felles radiosystem i det geografiske området som hører til Søndre Buskerud politidistrikt også medført betydelige oppgraderinger av telefonidelen i sentralene. For brann/redning har Nødnettprosjektet også medført et totalt nytt beslutningsstøttesystem.

Det har vært svært vanlig at våre intervjuobjekter lister vesentlige forbedringer som har skjedd innenfor nødmeldetjenesten i Buskerud i løpet av den tiden SAMLOK har eksistert, for så å kommentere at disse endringene ikke skyldes SAMLOK, men de mulighetene som har kommet og er blitt implementert i forbindelse med utrulling av Nødnett.

Det har derfor vært nødvendig å ta en del forbehold ved vurderingen av effekten av SAMLOK, som er det som dekkes av sluttevalueringsprosjektets mandat.

6.5. Sammenfallende eksterne faktorer

Som kjent planlegges det nå testing av felles nødnummer ved sentralene i Drammen.

Etablering og gjennomføring av tre så vidt krevende prosjekter som SAMLOK, implementering av Nødnett og testing av felles nødnummer som sammenfaller så vidt tett i tid medfører utfordringer av så vel teknisk som organisatorisk art.

Sett i forhold til vårt mandat, som gjelder evaluering av SAMLOK, er det vesentlig at dette tas inn som en faktor i planleggingen av piloten for felles nødnummer.

7. Konklusjoner og tilrådinger

Sluttevalueringen hemmes av at det bare i svært begrenset grad har vært mulig å fremskaffe virksomhetsdata, og at prosjektet derfor i stor grad måtte avgrenses til intervjuer med ansatte.

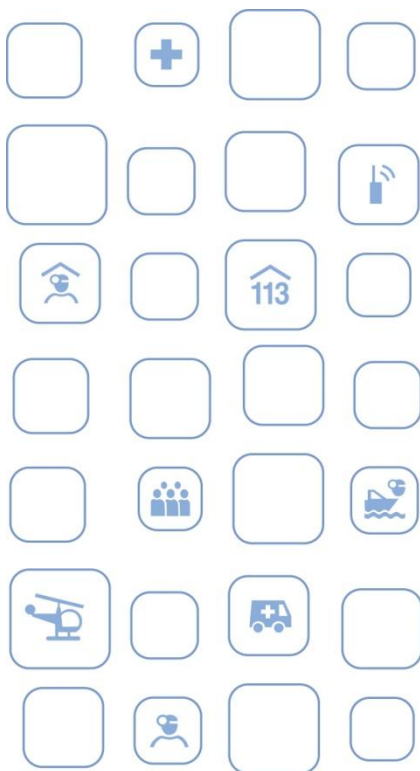
Likevel er det grunnlag for å trekke noen konklusjoner:

- Behov for bedre lokaler var en vesentlig del av bakgrunnen for SAMLOK. Det kan fastslås at dette er oppnådd.
- SAMLOK har gjennomgående ført til en «profesjonalisering» av tjenesten, der det har blitt nødvendig å legge mer vekt på dokumentasjon og formelle kontaktformer.
- SAMLOK har medført større gjensidig forståelse mellom de tre sentralene; at de lærer av hverandres erfaringer og implementerer dem (fagutvikling, organisering av team på sentralene, uniformering).
- Det ligger utfordringer i at sentralene har ulike geografiske nedslagsfelt.
- Utrulling av Nødnett som har medført at 110- og 113-sentralene må forholde seg til to radiosystemer er ikke optimalt.
- Ting som har skjedd parallelt i tid med implementering av SAMLOK (Nødnett, Utøya, generelle endringer i nødmeldetjenesten) medfører at det kan være vanskelig å skille effektene av SAMLOK per se fra øvrige faktorer.
- På grunn av ulike organisasjonsformer før SAMLOK har det ikke vært mulig å fastslå i hvilken grad SAMLOK har ført til endringer i kostnadsnivå i forhold til tidligere.
- Det ligger et gevinstpotensial som ikke er utløst i f.eks. samkjøring av tekniske løsninger.
- Det har ikke vært mulig å konkludere i forhold til økonomisk vinning eller tap ved implementering av SAMLOK. Dette fordi det ikke finnes sammenlignbare data fra sentralene før SAMLOK.
- Det planlegges et pilotprosjekt for felles nødnummer i forlengelsen av SAMLOK. Gjennom evalueringsarbeidet har det fremkommet momenter som det vurderes gunstig å ivareta ved gjennomføringen. Evaluering av denne typen prosjekter bør planlegges slik at den kan gjennomføres parallelt med de ulike fasene i prosjektprogresjonen, ikke begrenses til sent i prosjektforløpet.
- Ved gjennomføring av denne typen prosjekter er det vesentlig at det er en god forankring på lavere plan i nødetatene. Det kan være utfordrende å få stort nok materiale (antall intervjuobjekter) til å trekke sikre slutninger. Ved utarbeidelse av målbeskrivelse for slike prosjekter er det vesentlig at disse formuleres slik at de kan etterprøves ved en senere evaluering.
- For at et endringsprosjekt i nødmeldetjenesten skal medføre innovasjon, må dette fokuseres spesielt, og ressurser settes av til. Når sentraler fra ulike etater flytter sammen vil det være nyttig å ta hensyn til at tilgang til sentralen kan være en begrensende faktor for å beholde den uformelle kontakten mellom egen etat og sentralen.
- Ved samlokalisering av sentraler er det vesentlig å legge til rette for uformell/sosial kontakt mellom ansatte ved de ulike sentralene, for å lette formell samhandling og utveksling av kompetanse/ erfaringer. Det kan være svært krevende å måle effekten på kvalitet til publikum av endringer i nødmeldetjenesten. Dersom dette er aktuelt, må det planlegges tidlig i prosjektet for å sikre «før» og «etter» verdier.
- For å sikre maksimal gevinst av samlokalisering av sentraler er det nødvendig med en grundig planlegging og budsjettering av relevante teknologiske samordninger. (Pkt. 9.3)

KoKom
Møllendalsbakken 9
5009 Bergen

www.kokom.no
firmapost@kokom.no

Telefon: 55 97 72 60
Faks: 55 97 72 61



KVA ER KOKOM?

KoKom er eit akronym for "Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap". Senterets hovudoppgåve er å monitorere og vidareutvikle medisinsk nødmeldeteneste i Norge.

FORMÅL

KoKom skal bidra til at medisinsk nødmeldeteneste fungerer optimalt som ein del av helsetenesta. Medisinsk nødmeldeteneste er eit landsdekkande system som skal handtere melding, varslng og vidare oppfølging i akuttmedisinske situasjonar og elles når befolkninga har behov for kontakt med helsetenesta i vakt.

HOVUDOPPGÅVER

- Vere pådrivar for helsefagleg, administrativ og teknisk utvikling av medisinsk nødmeldeteneste og av kommunikasjonsberedskapen i helsetenesta.
- Sørge for utvikling og vedlikehald av nasjonale krav til medisinsk nødmeldeteneste i samråd med statlege myndigheiter.
- Vere katalysator for prosjekt som gjeld utvikling av medisinsk nødmeldeteneste gjennom eigen innsats, eller gjennom å framskaffe kompetanse frå anna hald.
- Medverke til rett bruk av medisinsk nødmeldeteneste.

BAKGRUNN

KoKom blei etablert av det dåverande Sosial- og helsedepartementet i 1997, som eit resultat av det arbeidet som vart utført for å oppnå eit nasjonalt einheitleg system for medisinsk nødmeldeteneste. Senteret er også eit kompetansesenter for kommunikasjon i den akuttmedisinske kjeda.

DAGLEG DRIFT

Sentrale arbeidsoppgåver knytt til medisinsk nødmeldeteneste:

- Kompetanseoppbygging
- Rådgjeving
- Aktiv deltaking i utvikling av systemkrav og einheitlege prosedyrar

Ansvar for medisinsk nødmeldeteneste er lagt til kommunar og helseføretak, noko som fører til at den medisinske nødmeldetenesta blir utvikla gjennom ein betydeleg lokal innsats. KoKom si oppgåve i dette er å bidra til ei aktiv og føremålstenleg erfaringsutveksling mellom dei ulike aktørane.